ANÁLISIS DE EMPRESA COTIZADA

# Cochlear Limited

COH · ASX (Australian Securities Exchange) · ISIN AU000000COH5 · Health Care

Fecha de corte de los datos: **8 oct 2026** · Divisa: **AUD** · Cifras en **millones**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recomendación<br>**Vender** | Precio<br>**129,00 AUD** | Objetivo 12 m<br>**150,07 AUD** | Rentabilidad 12 m<br>**+19,0 % (base +12,1 %)** |
| Valor intrínseco<br>**100,16 AUD · mercado 115,11** | Convicción<br>**Baja** | Capitalización<br>**8.437 M** | EV/EBITDA próx. 12 m<br>**15,0x** |
| Deuda neta aj. / EBITDA<br>**0,3x** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre | **Cochlear Limited** | Ticker / ISIN | **COH / AU000000COH5** |
| Mercado | **ASX (Australian Securities Exchange)** | Índice de referencia | **S&P/ASX 200** |
| Sector / industria | **Health Care / Health Care Equipment & Supplies** | Sede · fundación | **1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 (Sídney) · 1981** |
| Empleados | **5.400** | Web | **www.cochlear.com** |
| Precio (fecha) | **129,00 (8 oct 2026)** | Rango 52 semanas | **88,74 – 296,50** |
| Acciones diluidas (M) | **65,4** | | |
| Capitalización | **8.437 M AUD** | Valor empresa | **8.524 M AUD** |
| Volumen medio diario | **≈ 73,5 M AUD/día (3 meses, 65 sesiones hasta el 7-oct-2026)** | | |

## Contenido


- Síntesis y recomendación (una página)
- Resumen ejecutivo
- Parte I — Negocio y sector: 1. Historia · 2. Modelo de negocio · 3. Sector y mercado · 4. Posición competitiva
- Parte II — Finanzas: 5. Cuenta de resultados · 6. Resultados recientes · 7. Balance y circulante · 8. Flujos de caja · 9. Calidad contable · 10. Rentabilidad · 11. Deuda y solvencia · 12. Asignación de capital
- Parte III — Equipo y gobierno: 13. Equipo directivo · 14. Gobierno corporativo
- Parte IV — Mercado y valoración: 15. Consenso · 16. Bolsa · 17. Múltiplos históricos · 18. Comparables · 19. Transacciones · 20. DCF · 21. Escenarios · 22. Suma de partes · 23. Síntesis
- Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento: 24. Catalizadores · 25. Riesgos y pre-mortem · 26. ESG · 27. Preguntas abiertas · 28. Sentimiento en foros y comentarios
- Anexos: controles de calidad, información no disponible y fuentes
- Las secciones sin información verificable no se imprimen; quedan listadas en el anexo «Información no disponible».


No constituye recomendación de inversión.

## Síntesis y recomendación

**Vender** · Convicción Baja · Objetivo a 12 meses **150,07 AUD** frente a 129,00 · Rentabilidad a 12 meses **+19,0 % (base +12,1 %)** · Valor intrínseco 100,16 AUD · con la prima implícita del mercado: 115,11 (-10,8 %) · Alcista / bajista -3,0 % / -50,5 %

**La recomendación y por qué.** Vender, con convicción baja. El valor objetivo es de 100,16 AUD frente a un precio de 129,00 (−22,4 %; rentabilidad total esperada del −19,7 % con el dividendo); con la prima implícita del mercado, 115,11 (−8,1 % de rentabilidad total). Las dos reglas dan Vender, la relativa por muy poco: el alcista no compensa al bajista (asimetría de 0,47 con la prima del mercado y de −0,06 con nuestro coste de capital). La razón principal: tras caer un 55 % en un año, el precio todavía exige que el grupo crezca un 9,1 % anual durante diez años, cuando los implantes de adultos en países desarrollados crecieron un 1 % en FY2026. La convicción es baja porque la relativa está en el borde (−8,1 % frente al umbral del −10 %) y hasta FY2029 coincidimos con el consenso; subiría con otro recorte de la guía y bajaría si los adultos vuelven a crecer.

**El negocio.** Cochlear tiene más del 60 % del mercado mundial de implantes auditivos y un foso de costes de cambio: cada implantado compra procesadores de Cochlear de por vida, y los servicios ya son el 27 % de las ventas [1]. El ROIC fue del 21,7-26,6 % en FY2021-FY2025 y del 16,2 % en FY2026, por encima de un WACC del 10,46 %. Advanced Bionics, su rival cotizado, gana un 6,8 % [28]. La calidad sí sostiene el 5,5 % anual que proyectamos (el mercado, 7,6 %): pide poco capital nuevo y su cuota en implantes bajaría del 50 % al 40 % [27]. El problema no es el foso, sino el volumen: solo se implanta el 3 % de los adultos candidatos y la derivación depende del canal de audífonos [1].

**Finanzas.** Las ventas crecieron un 9,4 % anual en FY2021-FY2026, pero FY2026 se quedó en +2 % en moneda constante, con el margen EBITDA subyacente bajando 4,6 puntos, al 22,9 %, por mezcla hacia China y emergentes, menor absorción en fábrica y divisa [1]. Sin deuda y con 188 M de caja neta, el balance no es el riesgo; el circulante, sí: absorbió 308 M antes del lanzamiento de Nexa y aún está en el 32 % de las ventas.

**Equipo y gobierno.** Consejo independiente, una acción un voto, sin accionista de control y remuneración ligada al BPA y al TSR relativo [1]. Resta la credibilidad: dos guías anuales recortadas seguidas, la de FY2026 un 31 % en el punto medio en abril, y una demanda colectiva por ello [15, 26]. Siete consejeros compraron acciones en los últimos doce meses [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75].

**Valoración.** El DCF da 92,21 (WACC del 10,46 %, crecimiento terminal del 3 %); los comparables, 122,41 (128,25 por EV/EBITDA de los próximos 12 meses y 116,56 por PER): Cochlear ya cotiza en su mediana (15,0 veces el EBITDA frente a 14,9) sin crecer más que ellos. Nuestra proyección coincide con el consenso hasta FY2029 [82]; la diferencia está después: suponemos un máximo del 7 % de crecimiento y un margen del 27 %, y el precio pide un 9,1 % anual o un margen del 34,7 %. La rentabilidad anual implícita en el precio es del 8,5 %, por debajo del 9,25 % que pide el mercado.

**Riesgos y catalizadores.** El riesgo para esta recomendación es al alza: que el Capital Markets Day del 13-nov-2026 muestre que la derivación médica de adultos funciona (los hospitales privados australianos crecieron un 15 % en FY2026) [1, 100]. A la baja, el bajista (63,90, −50,5 %) es FY2026 repetido; China y el dólar australiano restan margen.

**Qué cambiaría la decisión.** Compraríamos por debajo de 98,66 y mantendríamos entre 98,66 y 128,20. Pasaríamos a Mantener si en febrero de 2027 los implantes de desarrollados crecen más de un 5 % en moneda constante, o si el margen bruto vuelve al 72 %.

# Resumen ejecutivo

*Confianza: Media*

**Recomendación: Vender** · Convicción: Baja · Horizonte: 12 meses · Objetivo a 12 meses: **150,07 AUD** (rentabilidad +19,0 % (base +12,1 %)) · Valor intrínseco: 100,16 AUD (-22,4 % sobre 129,00) · con la prima implícita del mercado: 115,11 (-10,8 %)

Cochlear es el líder mundial de los implantes auditivos, con más del 60 % de cuota, un negocio de servicios cautivo del 27 % de las ventas y un ROIC del 21,7-26,6 % en FY2021-FY2025 sin deuda [1]. Lo que lo hacía valioso era el crecimiento de los adultos en países desarrollados, del ≈ 10 % anual durante años [1]; en FY2026 ese motor se paró (+1 % en desarrollados) y el margen EBITDA subyacente cayó al 22,9 % [1].

El precio de 129,00 AUD, tras una caída del 55 % en un año, sigue descontando mucho: con nuestros márgenes exige un crecimiento del 9,1 % anual durante diez años, por encima del 7,3 % de la década anterior y del 4,4 % anual que da el consenso hasta FY2029 [82]. A 15,0 veces el EBITDA de los próximos 12 meses cotiza en la mediana de sus comparables, que crecen más y tienen mejores márgenes.

Para invertir hay que creer que la medicalización de la pérdida auditiva devuelve a los adultos al crecimiento de dos dígitos en dos o tres años y que el margen vuelve al objetivo del 18 % neto. Es posible, pero la empresa lo ha prometido sin cumplirlo dos años seguidos, y China, el dólar australiano y el fin del ciclo de procesadores juegan en contra. El mercado acierta al bajar el múltiplo; se equivoca, a nuestro juicio, en suponer que la recuperación ya está asegurada.

## La decisión

| Elemento de la decisión | Valor |
|---|---|
| **Objetivo a 12 meses (nuestro PER × nuestro BPA FY2028e, ponderado 25/50/25)** | 150,07 AUD |
| **Bajista / base / alcista a 12 meses** | 24,7x × 4,51 = 111,40 · 25,2x × 5,60 = 141,12 · 32,7x × 6,32 = 206,66 |
| **Rentabilidad a 12 meses: ponderada / del base (con dividendo)** | 19,0 % / 12,1 % |
| **Regla de múltiplos aplicada** | v2: base = mín(actual, mediana 5 a) con la historia al cierre; bajista mín. 5 a o base × 0,85; alcista techo base × 1,30 |
| **Objetivo medio de los analistas (solo contraste)** | 137,09 (nuestro base +2,9 %) |
| **Valor intrínseco (síntesis ponderada, largo plazo)** | 100,16 AUD |
| **Potencial sobre el precio actual** | -22,4 % |
| **Rentabilidad por dividendo ordinario** | 2,7 % |
| **Rentabilidad total esperada a 12 meses** | -19,7 % |
| **Escenario alcista / bajista** | -3,0 % / -50,5 % |
| **Asimetría (ganancia alcista / pérdida bajista)** | -0,06x |
| **Rentabilidad anual implícita en el precio frente al WACC y al que pide el mercado** | 8,5 % frente a 10,5 % y 9,3 % |
| **Valor objetivo con la prima implícita del mercado (4,2 %, WACC 9,3 %)** | 115,11 AUD |
| **Rentabilidad total esperada con la prima del mercado** | -8,1 % |
| **Asimetría con la prima del mercado** | 0,47x |
| **Regla absoluta (frente a su coste de capital)** | Vender |
| **Regla relativa (frente a lo que pide el mercado)** | Vender |
| **Crecimiento anual implícito en el precio (FY2027e-FY2036e) frente al previsto para su mercado** | 9,1 % frente a 7,6 % |
| **¿La calidad de la empresa sostiene el crecimiento previsto?** | Sí (5,5 % anual proyectado; sin inversión neta) |

| Elemento de la decisión | Valor |
|---|---|
| **Señal del valor intrínseco (regla del DCF, referencia)** | Vender |
| **Recomendación según la regla a 12 meses (Comprar: ponderada ≥ 15 %, base ≥ 12 % y valor intrínseco ≥ precio; Vender: ponderada ≤ -10 %)** | Mantener |
| **Convicción según los criterios (la rentabilidad que decide (-8,1 %) está a menos de 3 puntos del umbral de Vender (-10 %))** | Baja |

Regla (método v2): la recomendación sigue al objetivo a 12 meses, que es nuestro PER × nuestro BPA del ejercicio que mirará el mercado dentro de un año, con la misma regla de múltiplos para todas las empresas (base: el menor entre el PER actual y la mediana de 5 años; bajista: el mínimo de 5 años, o el base −15 % si ya cotiza por debajo; alcista: la media histórica o la de los comparables, sin pasar de base +30 %), ponderado con las probabilidades de los escenarios. Comprar si la rentabilidad ponderada es ≥ 15 %, la del base ≥ 12 % y el valor intrínseco no queda por debajo del precio; Vender si la ponderada es ≤ −10 %; Mantener en el resto. El consenso de analistas solo se compara. El valor intrínseco (DCF) es la referencia a largo plazo; su regla, la de siempre: Comprar si la rentabilidad total esperada a 12 meses es ≥ 15 % y el alcista gana al menos lo que pierde el bajista; Vender si es ≤ −10 %, o negativa con asimetría < 0,5; Mantener en el resto. Se aplica dos veces: con el WACC del análisis (regla absoluta: ¿rinde más que su coste de capital?) y con el WACC que resulta de la prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa: ¿rinde más que lo que hoy pide el mercado, ajustado por su beta?). Manda la relativa, salvo que las dos se contradigan (una Comprar y otra Vender): entonces, Mantener.

| Acción | A qué precio |
|---|---|
| **Comprar** | Por debajo de 100,16 (ponderada a 12 meses ≥ 15 %, base ≥ 12 % y precio ≤ valor intrínseco) |
| **Mantener** | Entre 100,16 y 170,58 |
| **Vender o reducir** | Por encima de 170,58 (ponderada a 12 meses ≤ -10 %) |

## Qué cambiaría la recomendación

- Si el precio baja de 98,66 AUD, pasaríamos a Comprar.
- Si los implantes en desarrollados crecen más de un 5 % en moneda constante en el primer semestre de FY2027, pasaríamos a Mantener.
- Si el Capital Markets Day fija un objetivo de margen neto del 18 % con fecha y un crecimiento de adultos respaldado por datos de derivación, revisaríamos la base al alza.
- Si la empresa vuelve a recortar la guía de FY2027 (330-350 M), mantendríamos Vender con convicción media.

## Dónde discrepamos del mercado

**Lo que descuenta el precio.**

Que lo peor ha pasado: el consenso sigue la guía de FY2027 (330-350 M de beneficio subyacente) y espera un crecimiento del 5,6 % en FY2028 y del 6,9 % en FY2029 [82]; con el precio actual, el grupo debe volver después a crecer un 9 % anual. Catorce de dieciséis analistas dicen mantener, con un precio objetivo medio de 137,09 [83].

**Lo que creemos nosotros.**

Coincidimos con el consenso hasta FY2029, pero no vemos recorrido para volver al 9-10 % sostenido: suponemos un máximo del 7 % y un margen EBITDA del 27 %, por debajo del objetivo de la empresa. Con un bono australiano al 5,34 %, eso vale 92,21 AUD por acción, o 111,95 con la prima del mercado.

**Por qué podemos tener razón.**

Los adultos dependen de derivaciones del canal de audífonos y de la capacidad hospitalaria, que la empresa no controla (solo el 40 % de las derivaciones en EE. UU. viene del canal médico) [1]; China ya ha bajado el precio un 75 % en la licitación nacional [32]; los servicios crecerán menos al madurar el ciclo del Nucleus 8 [1]. Y la dirección ha fallado dos guías seguidas.



| Método | Valor por acción | Potencial | Peso |
|---|---|---|---|
| **DCF** | 92,21 | -28,5 % | 40 % |
| **Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)** | 122,41 | -5,1 % | 25 % |
| **Transacciones precedentes (no se usa)** | 130,75 | +1,4 % | 0 % |
| **Escenarios ponderados** | 93,37 | -27,6 % | 35 % |

## A favor

- **Foso de costes de cambio**: más del 60 % de cuota y servicios cautivos del 27 % de las ventas (634,9 M en FY2026) [1].
- **Balance sin deuda**: 187,7 M de caja neta y 350 M de líneas sin disponer [1].
- **Rentabilidad alta**: ROIC del 21,7-26,6 % en FY2021-FY2025, más del doble del WACC del 10,46 %.
- **Mercado sin penetrar**: solo el 3 % de los adultos candidatos de países desarrollados tiene un implante [1].
- **Tecnología**: Nexa ya es más del 95 % de los implantes en desarrollados, con una subida media de precio del 3 % [1].
- **Compras de consejeros**: siete consejeros compraron en mercado en los últimos doce meses, ninguno vendió [69, 70, 71, 72, 73, 74, 75].

## En contra

- **Precio exigente**: el DCF inverso pide un crecimiento del 9,1 % anual durante diez años, frente a un 5,5 % en nuestra base.
- **Adultos parados**: implantes en desarrollados +1 % en moneda constante en FY2026; Europa occidental −8 % [1].
- **Margen a la baja**: margen EBITDA subyacente del 22,9 % en FY2026, 4,6 puntos menos, y guía de margen bruto del 70-71 % [1].
- **Credibilidad**: guía de FY2026 recortada un 31 % en el punto medio y demanda colectiva de accionistas [15, 26].
- **China y divisa**: licitación con precios un 75 % más bajos y un AUD que resta un 10 % al beneficio de FY2027 [1, 32].

## Qué tiene que pasar para que la tesis funcione

La tesis depende del crecimiento de los implantes de adultos en países desarrollados. Si en el primer semestre de FY2027 (febrero de 2027) crecen más de un 5 % en moneda constante y el margen bruto se mantiene en el 70-71 % de la guía, la recuperación que descuenta el precio empieza a ser creíble. Si crecen menos de un 3 %, el bajista (63,90) gana peso. La otra señal es el Capital Markets Day del 13-nov-2026: un objetivo de crecimiento a medio plazo sin fechas ni cifras de derivación sería otra promesa.

## Indicadores de seguimiento

| Indicador | Nivel actual | Umbral de alerta | Por qué importa |
|---|---|---|---|
| **Crecimiento de implantes en desarrollados (moneda constante)** | +1 % en FY2026 | < 3 % en el primer semestre de FY2027 | Es la variable que separa la base del bajista. |
| **Margen bruto** | 71 % en FY2026 | < 70 % | Mide el precio en China y la absorción en fábrica. |
| **Beneficio neto subyacente FY2027** | Guía 330-350 M | Cualquier recorte de la guía | Tercera guía fallida seguida. |
| **Circulante sobre ventas** | 32,0 % | > 33 % | La caja neta (188 M) depende de que baje. |
| **Crecimiento de servicios (moneda constante)** | +6 % en FY2026 | < 3 % | Fin del ciclo del Nucleus 8: es el 27 % de las ventas. |

## Datos clave

| | | | |
|---|---|---|---|
| EV/EBITDA últimos 12 m / próx. 12 m | **15,8x / 15,0x** | PER últimos 12 m / próx. 12 m | **57,4x / 27,1x** |
| EV/EBIT últimos 12 m | **19,7x** | | |
| EV/Ventas últimos 12 m | **3,63x** | Rentabilidad por FCF | **2,9 %** |
| Rentabilidad por dividendo | **2,7 %** | Crecimiento anual de ingresos (FY2021-FY2026) | **9,4 %** |
| Margen EBITDA últimos 12 m | **22,9 %** | ROIC último ejercicio | **16,2 %** |
| WACC | **10,5 %** | Deuda neta / EBITDA (contable · ajustada) | **0,0x · 0,3x** |
| Gobierno (criterios cumplidos) | **12 de 13 (1 sin dato)** | | |

# Parte I — Negocio y sector

## 1. Historia e hitos

*Confianza: Alta*

Cochlear nace en 1981 dentro del grupo Nucleus del empresario Paul Trainor para comercializar, con la Universidad de Melbourne y fondos del Gobierno australiano, el implante multicanal Nucleus 22 que había desarrollado el cirujano Graeme Clark [1]. Sale a la ASX en 1995 [1]. Desde entonces ha invertido unos 3.000 M AUD en I+D (≈ 12 % de las ventas cada año), acumula más de 2.300 patentes y solicitudes y más de 800.000 personas implantadas [1]. Los dos golpes de su historia cotizada son la retirada mundial del CI500 en 2011 y el ejercicio 2020, con una sentencia adversa de patentes y la COVID que obligaron a ampliar capital y suspender el dividendo [1, 5]. En 2024 absorbió la base de implantes cocleares de Oticon Medical a precio cero [21] y en 2025-26 lanzó la plataforma Nexa, a la que siguió un recorte de previsiones en abril de 2026 [1, 26].

| Año | Hito |
|---|---|
| **1981** | Cochlear empieza a operar dentro del grupo Nucleus para comercializar el implante multicanal Nucleus 22 de Graeme Clark [1]. |
| **1995** | Salida a bolsa en la ASX [1]. |
| **2011** | 11-sep-2011: retirada voluntaria mundial de los implantes Nucleus CI500 no implantados; aún hay demandas de pacientes, cubiertas por el seguro de responsabilidad de producto [1]. |
| **2020** | Sentencia adversa en un litigio de patentes y COVID: pérdida estatutaria de 238,3 M AUD, ventas −6,5 % (1.352,3 M frente a 1.446,1 M en FY2019), ampliación de capital y dividendo suspendido en marzo de 2020 [5]. |
| **2022** | 27-abr-2022: acuerdo para comprar Oticon Medical a Demant por 850 M DKK (≈ 170 M AUD), con más de 75.000 pacientes de implantes [17]. |
| **2023** | 22-jun-2023: la CMA británica prohíbe la compra del negocio de conducción ósea (Ponto) y deja pasar solo los implantes cocleares, a precio cero [19]. |
| **2024** | 21-may-2024: cierre de la compra del negocio de implantes cocleares de Oticon Medical (≈ 20.000 pacientes) a precio cero, con ≈ 30 M AUD de costes de integración en FY24 [21]. |
| **2025** | Lanzamiento del Nucleus Nexa, primer implante coclear con firmware actualizable, y del Kanso 3 Nexa; en junio de 2026 era más del 95 % de las ventas de implantes en mercados desarrollados, con una subida media de precio del 3 % [1]. |
| **2026** | 22-abr-2026: recorte de la previsión de beneficio subyacente de FY26 a 290-330 M AUD por debilidad en mercados desarrollados y Oriente Medio [26]; 29-sep-2026: demanda colectiva de accionistas en el Tribunal Supremo de Victoria por esa previsión [15]. |

## 2. Modelo de negocio

*Confianza: Alta*

Cochlear diseña, fabrica y vende implantes auditivos: implantes cocleares Nucleus (61 % de las ventas de FY26), servicios, que son sobre todo procesadores de sonido de reemplazo y accesorios para los ya implantados (27 %), y Acoustics, implantes de conducción ósea Osia y Baha (12 %) [1]. Vende en más de 180 países con más de 5.400 empleados y seis plantas, entre ellas Australia, Suecia, Malasia y China (Chengdu) [1]. Sus clientes directos son gobiernos, universidades públicas, clínicas, grandes cadenas hospitalarias y distribuidores [1]; quien paga es casi siempre un sistema público, un seguro o Medicare. Más del 95 % de los ingresos se generan fuera de Australia [1]. En FY26 vendió 56.692 implantes cocleares (+5 %) y ha implantado a más de 800.000 personas desde su fundación [1].

### Cómo gana dinero

El implante se vende una vez, normalmente a un hospital o a una licitación, y abre una relación de por vida: el procesador externo se renueva cada pocos años, y esa base instalada sostiene la línea de servicios (634,9 M AUD en FY26, +6 % en moneda constante; +13 % en mercados desarrollados) [1]. En FY26 más de 53.000 implantados cambiaron al último procesador [1]. El margen depende del precio y de la mezcla: la plataforma Nexa permitió subir el

precio un 3 % de media en mercados desarrollados, pero el mayor peso de unidades baratas de mercados emergentes y la compra centralizada china restaron 1,5 puntos al margen bruto, que bajó del 74 % al 71 % [1]. La I+D es un coste casi fijo del 12-14 % de las ventas (323 M AUD en FY26) [1].

## Segmentos (FY2026)

| Segmento | Ingresos | % del total | Crecimiento | Margen | Tipo de margen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Americas** | 1.153 | 49,1 % | +1,4 % | 49,5 % | EBIT |
| **EMEA** | 804 | 34,2 % | +1,7 % | 40,5 % | EBIT |
| **Asia Pacific** | 387 | 16,5 % | -9,9 % | 18,9 % | EBIT |
| **Corporativo y no asignado** | 4 | 0,2 % | -133,1 % | -17.911,9 % | EBIT |




| Ingresos por segmento | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Americas** | 780 | 978 | 1.141 | 1.137 | 1.153 |
| **EMEA** | 579 | 639 | 746 | 790 | 804 |
| **Asia Pacific** | 283 | 338 | 372 | 429 | 387 |
| **Corporativo y no asignado** | 7 | -20 | -23 | -13 | 4 |




## Clientes, recurrencia y poder de precios

No hay concentración de clientes: la mayor cuenta a cobrar con un solo cliente era de 24,4 M AUD a 30-jun-2026 (30,0 M un año antes), alrededor del 1 % de las ventas [1]. El riesgo está en el pagador y en el calendario: las licitaciones públicas y los distribuidores hacen irregulares las ventas en emergentes, y Cochlear pide a veces cartas de crédito [1]. El poder de precio existe en desarrollados (subida media del 3 % con Nexa en FY26 [1]) pero no en las compras centralizadas: en China la licitación nacional de diciembre de 2024 bajó el precio medio de un implante de más de 200.000 a unos 50.000 CNY (−75 %) para 11.000 unidades repartidas entre cinco proveedores, Cochlear incluida [31, 32]. La duración de la relación es la vida del paciente: Cochlear se compromete a dar procesadores compatibles con implantes de hace décadas, y lo extendió a los ≈ 20.000 pacientes de Oticon Medical [21].

### Indicadores operativos

| Indicador | Anterior | Actual | Variación | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| **Unidades de implante coclear** | 53.968 | 56.692 | +5 % | Más unidades de mercados emergentes de menor precio; ingresos de implantes planos en moneda constante [1]. |
| **Crecimiento de ventas en moneda constante** | +3 % | +2 % | -1 pp | Reportado: +4 % en FY25 y -1 % en FY26 [1, 2]. |
| **Margen bruto (sobre ventas)** | 74 % | 71 % | -3 pp | Mezcla -1,5 pp, variaciones de fabricación -1,2 pp, divisa -0,6 pp; guía FY27 70-71 % [1, 6]. |
| **I+D sobre ventas** | 12 % | 14 % | +2 pp | I+D 323,2 M (+15 %): electrodo con fármaco e implante totalmente implantable; guía FY27 13 % [1, 6]. |
| **Ventas de mercados desarrollados (moneda constante)** | n.d. | +1 % | n.d. | EE. UU. +4 %, Europa Occidental -8 %; Services desarrollados +13 % [1]. |
| **Ventas de mercados emergentes (moneda constante)** | n.d. | -2 % | n.d. | Latinoamérica y Europa del Este crecen; Oriente Medio (conflicto) y China (compras centralizadas) caen [1]. |
| **Crecimiento por línea en moneda constante (Implantes / Services / Acoustics)** | +9 % / -10 % / +6 % | 0 % / +6 % / +1 % | n.d. | FY25 frente a FY24 y FY26 frente a FY25 [1, 2]. |
| **Cuota global de implantes cocleares** | n.d. | >60 % | n.d. | Dato de la empresa [1]. |

## 3. Sector y mercado

*Confianza: Media*

El mercado relevante son los implantes auditivos: implantes cocleares para pérdida neurosensorial severa o profunda (sistema, procesadores de reemplazo y accesorios) y, como nicho, los implantes de conducción ósea para pérdida conductiva o mixta y sordera unilateral [1, 20]. Es mundial, con tres fabricantes occidentales (Cochlear, MED-EL y Advanced Bionics de Sonova) y dos chinos que ganaron la licitación nacional de 2024 (Nurotron y Listent) [32]. Para el tamaño usamos Global Market Insights (≈ 2.000 M USD en 2025, solo implantes cocleares) [27]; cuadra con las cuentas: el 49,5 % que atribuye a Cochlear son ≈ 990 M USD, lo que facturó Cochlear en implantes en FY26 (1.435 M AUD) [1, 27]. Si se suman servicios y conducción ósea, el mercado es mayor: con ventas de 2.343 M AUD y la cuota de más del 60 % que se atribuye Cochlear, rondaría los 3.900 M AUD (estimación propia).

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tamaño del mercado | **≈ 2.000 M USD en 2025 solo en implantes cocleares, ≈ 2.880 M AUD al cambio de la fecha de corte [27, 35]; ≈ 3.900 M AUD incluyendo procesadores de reemplazo y conducción ósea (estimación propia: ventas de Cochlear de 2.343 M AUD / cuota del 60 %) [1].** | Posición en el ciclo | **Madurez del ciclo** |
| Crecimiento histórico anual | **11,3 %** | Crecimiento previsto anual | **7,6 %** |
| Cuota de los 5 primeros | **87 %** | Estructura | **Concentrada** |



## Motores de la demanda

| Motor | Efecto | Horizonte | Evidencia |
|---|---|---|---|
| **Envejecimiento y prevalencia de la pérdida severa** | + | Estructural | Más de 60 millones de personas con pérdida severa o mayor según la OMS; el 65 % de los mayores de 60 años tiene pérdida auditiva y uno de cada cuatro, moderada o mayor [1]. En EE. UU. la población de más de 65 años crece 3,5 veces más rápido que la total entre 2020 y 2035 [24]. |
| **Penetración en adultos y mayores de países desarrollados** | + | Estructural | Unos 6 millones de candidatos y una penetración del ≈ 3 % (≈ 5 % en el Capital Markets Day de 2023), frente a más del 80 % en niños menores de 3 años [1, 24]. Más del 75 % de los candidatos en EE. UU. son ya adultos o mayores [24]. |
| **Ampliación de indicaciones y reembolso** | + | Estructural | Medicare amplió la cobertura a un espectro más amplio de pérdida auditiva; Japón, Reino Unido y Bélgica incluyeron la pérdida severa; la FDA aprobó el implante para sordera unilateral y bajó la edad mínima a 9 meses [1, 24]. Medicare paga 33.686 USD por la cirugía ambulatoria de implante (APC 5166) en 2026 [33]. |
| **Compras centralizadas y precio en emergentes** | – | Estructural | La licitación china de diciembre de 2024 bajó el precio medio un 75 %, a ≈ 50.000 CNY [31, 32]; en FY26 China restó a Cochlear por menor precio y por el recorte del reembolso en las zonas de acceso especial desde el segundo semestre [1]. AB cayó un 10,3 % en sistemas por China [28]. |
| **Capacidad hospitalaria, derivaciones y confianza del consumidor** | +/– | Cíclico | En el tercer trimestre de FY26 los implantes en desarrollados quedaron planos: listas de espera en Reino Unido y Alemania, huelgas en Italia y España, menos derivaciones desde las audioprotesistas y la confianza del consumidor de EE. UU. en mínimos [26]. |
| **Ciclo de renovación de procesadores** | +/– | Cíclico | Servicios de Cochlear +13 % en desarrollados en FY26 por Nucleus 8 y la retirada del procesador anterior [1]; en AB, las mejoras cayeron un 13,1 % porque la mayoría ya tenía el Marvel de 2021 [28]. |

## Las cinco fuerzas

Amenaza de entrada

Poder de los proveedores

| Fuerza | Intensidad (1-5) | Justificación |
|---|---|---|
| **Rivalidad** | 3 | Tres fabricantes occidentales se reparten casi todo el mercado (los cinco primeros, 87 % [27]). La rivalidad es por tecnología y no por precio en desarrollados (Cochlear subió un 3 % con Nexa [1]), pero el lanzamiento de Nexa le quitó ventas a AB en el segundo semestre [25] y en Acoustics la competencia le restó ventas a Cochlear en EE. UU. y Reino Unido [1]. |
| **Poder de los clientes** | 4 | Pagan gobiernos, aseguradoras y Medicare. En China, la licitación central bajó el precio un 75 % [32]; en desarrollados, las tarifas como la APC 5166 de Medicare (33.686 USD en 2026 [33]) fijan cuánto cobra el hospital, y los recortes de reembolso de China en 2026 bajaron el precio medio de Cochlear [1]. |
| **Poder de los proveedores** | 2 | Cochlear fabrica en seis plantas propias, en Australia, Suecia, Malasia y China [1]. Margen bruto del 71-74 % [1]: los componentes no son la restricción; el riesgo citado es de continuidad del suministro, aranceles y fletes [1]. |
| **Amenaza de entrada** | 2 | Hacen falta décadas de I+D (Nexa: 20 años desde la investigación hasta el lanzamiento [1]), ensayos clínicos, aprobación de la FDA y del MDR y una red de cirujanos. Demant abandonó los implantes en 2022-2026 [17, 29]. La entrada real es la china, protegida por la licitación nacional: Nurotron y Listent ganaron plaza en 2024 [32]. |
| **Amenaza de sustitutos** | 2 | Para pérdida severa o profunda, el audífono da peores resultados, pero sigue siendo la primera opción: solo el 4 % de ese segmento lleva implante coclear [1]. Las derivaciones dependen del canal de audífonos, que cayó en 2026 [26]. Una terapia génica o regenerativa sería el sustituto real, sin fecha conocida. |

## Ciclo

No es un sector cíclico de demanda, pero depende de la cirugía programada. En 2020 las ventas de Cochlear cayeron un 6,5 % (1.352,3 M AUD frente a 1.446,1 M en FY2019) por los aplazamientos de la COVID y se recuperaron en FY2021 hasta 1.493,3 M (+10 %) [5]. En 2026 vuelve a frenar por capacidad hospitalaria y confianza del consumidor, sin cambio en la necesidad clínica [26]: el crecimiento de implantes en desarrollados fue plano en el tercer trimestre de FY26 [26]. Lo indican las listas de espera, las derivaciones del canal de audífonos y las licitaciones en emergentes. No hay datos homogéneos de 2008-09 en las fuentes leídas.

## Regulación

En EE. UU. Medicare amplió en el ejercicio 2023 de Cochlear (jul-2022 a jun-2023) la cobertura a un espectro más amplio de pérdida auditiva y la FDA ha extendido las indicaciones a sordera unilateral y a niños desde 9 meses [1, 24]. La cirugía ambulatoria se paga por la APC 5166 (la del implante coclear, código CPT 69930) [34]: 33.686 USD en 2026 (regla final del 21-nov-2025) [33]; la propuesta para 2027 (CMS-1850-P, julio de 2026) no se ha podido contrastar para esta APC. Los implantes entran en EE. UU. sin arancel por un capítulo del arancel armonizado; Cochlear lo confirmó en abril de 2025 y otra vez el 24-jul-2026 tras la investigación de la Sección 301 [22, 23]. En China, la compra centralizada rige desde marzo de 2025 con ciclos de tres años [32]. Las autoridades de competencia (CMA, ACCC) vetaron en 2023-24 que Cochlear comprara el negocio de conducción ósea de Oticon Medical [19, 20].

## Tendencias y disrupción

Tres tecnologías pueden mover cuotas. El implante actualizable por firmware (Nexa, solo de Cochlear) ya es el 95 % de sus ventas en desarrollados [1]. El implante totalmente implantable, sin procesador externo: Cochlear tiene dos estudios de registro en marcha [26] y MED-EL operó el primero en Europa en 2020 en un estudio de viabilidad [37]. Y el electrodo que libera fármaco: Cochlear tiene dos estudios ya reclutados [26]. AB prepara un procesador nuevo para el segundo semestre de su ejercicio 2026/27 [25]. En demanda, la medicalización de la pérdida auditiva (vínculo con demencia y caídas) y la publicidad directa al paciente ganan peso [1]. La cadena de derivación depende del canal de audífonos, que se debilitó en 2026 [26].

# 4. Posición competitiva y foso

*Confianza: Media*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cuota de mercado | **60,0 %** | Posición | **1.° mundial en implantes auditivos: más del 60 % de cuota global en implantes cocleares y de conducción ósea según la propia empresa [1]; GMI le da el 49,5 % del mercado de implantes cocleares en 2025 [27]. En el segmento más amplio de la pérdida severa o mayor, donde dominan los audífonos, tiene ≈ 4 % [1].** |
| Foso | **Amplio** | Tendencia del foso | **Estable** |

| Competidor | País | Cotiza | Ingresos (M) | M. EBIT | Cómo compite |
|---|---|---|---|---|---|
| **Advanced Bionics (segmento Cochlear Implants de Sonova)** | Suiza / EE. UU. | SOON (SIX, Sonova) | 458 | 6,8 % | Ventas de 252,1 M CHF en el ejercicio a marzo de 2026, −11,1 % en moneda local (303,9 M CHF un año antes); sistemas 179,6 M y mejoras y accesorios 72,5 M. El margen es EBITA normalizado (6,8 %, desde 11,4 %); el EBITA reportado fue una pérdida de 34,6 M CHF (−13,7 %) por costes legales y una provisión por un producto antiguo. Perdió por la licitación china y por el lanzamiento del mayor competidor en el segundo semestre [25, 28]. Convertido a 1,8156 AUD/CHF [35]. |
| **MED-EL** | Austria | – | – | – | Privada, fundada y dirigida por Ingeborg Hochmair, con sede en Innsbruck; más de 3.300 empleados, implantes en más de 140 países y la única con cartera completa de implantes auditivos, según su web [36, 38]. No publica cuentas. Ganó plaza en la licitación china de 2024 [32] y operó el primer implante totalmente implantable en Europa en 2020 [37]. |
| **Nurotron Biotechnology** | China | – | – | – | Fabricante local (Hangzhou) que ganó plaza en la licitación nacional china de diciembre de 2024, con precio medio de ≈ 50.000 CNY por implante [31, 32]. Compite por precio en el mercado chino. |
| **Listent (Shanghai Lishengte Medical Technology)** | China | – | – | – | Segundo fabricante chino adjudicatario en la licitación nacional de 2024 [32]. |
| **Oticon Medical (Ponto), hoy de Impilo** | Dinamarca / Suecia | – | – | – | Rival en conducción ósea (Ponto) frente a Baha y Osia. La CMA británica impidió en 2023 que Cochlear lo comprara y Demant se lo quedó [19, 20]; Demant lo vendió a Impilo por hasta 600 M DKK (325 M en efectivo al cierre) el 22-oct-2025, con cierre el 31-mar-2026 [29, 30]. Los procesadores Baha de Cochlear son compatibles con los implantes Ponto [19]. |




## Fuentes de ventaja competitiva




| Fuente | Puntuación (0-5) | Evidencia |
|---|---|---|
| **Efectos de red** | 2 | Red de cirujanos y audiólogos formados en su sistema y programas de derivación; donde Cochlear controla la derivación crece más rápido (cirugías por publicidad directa +10 % en EE. UU. en FY26) [1]. No hay efecto de red entre pacientes. |
| **Costes de cambio** | 5 | El implante queda en el paciente de por vida y solo admite procesadores de su fabricante: servicios de 634,9 M AUD (27 % de las ventas) cautivos, y más de 53.000 implantados se pasaron al último procesador en FY26 [1]. Por eso Cochlear asumió a los ≈ 20.000 pacientes de Oticon Medical [6]. |
| **Intangibles (marca, patentes, licencias)** | 4 | Más de 2.300 patentes y solicitudes, 3.000 M AUD de I+D acumulada, fiabilidad acumulada del 99,76 % del Profile Plus a siete años, y el único implante con firmware actualizable (Nexa) [1]. Las autorizaciones de la FDA y las indicaciones nuevas exigen años de ensayos [1]. |
| **Ventaja en costes** | 3 | Margen bruto del 71 % en FY26 (74 % en FY25) [1] frente a un EBITA normalizado del 6,8 % en AB [15]: la escala reparte la I+D (323 M AUD, más que las ventas totales del segmento de AB) [1, 15]. Pierde ventaja en China, donde el precio lo fija la licitación [19]. |
| **Escala eficiente** | 4 | Un mercado de ≈ 2.000 M USD en implantes cocleares [14] solo sostiene a unos pocos fabricantes: Demant salió con pérdidas (Oticon Medical en pérdidas al venderse) [2, 4, 16] y AB tiene márgenes de un dígito [15]. |

## Amenazas

La mayor es tecnológica: que un rival llegue antes con el implante totalmente implantable o con un procesador que iguale a Nexa; AB anuncia un procesador nuevo para la segunda mitad de su ejercicio 2026/27 [25], y MED-EL lleva desde 2020 probando el suyo totalmente implantable [37]. La segunda es de precio: la compra centralizada china (−75 %) [32] puede extenderse a otros países con licitación pública. La tercera es la cadena de derivación: si los audífonos (y los de venta libre) retrasan la llegada al cirujano, el mercado de adultos crece menos, como en 2026 [26]. En conducción ósea, Impilo es un dueño nuevo y centrado solo en Ponto [29].

# Parte II — Finanzas

## 5. Cuenta de resultados

*Confianza: Alta*

| Periodo | Ingresos | Crec. | M. bruto | EBITDA | M. EBITDA | EBIT | M. EBIT | B. neto | BPA | DPA | Tipo imp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 1.498 | – | 72,6 % | 403 | 26,9 % | 326 | 21,8 % | 324 | 4,93 | 2,55 | 11 % |
| **FY2022** | 1.648 | +10,1 % | 75,1 % | 477 | 29,0 % | 404 | 24,5 % | 289 | 4,40 | 3,00 | 27 % |
| **FY2023** | 1.936 | +17,5 % | 74,8 % | 516 | 26,6 % | 435 | 22,4 % | 301 | 4,56 | 3,30 | 24 % |
| **FY2024** | 2.236 | +15,5 % | 74,9 % | 620 | 27,7 % | 535 | 23,9 % | 357 | 5,43 | 4,10 | 26 % |
| **FY2025** | 2.343 | +4,8 % | 73,7 % | 644 | 27,5 % | 554 | 23,6 % | 389 | 5,93 | 4,30 | 25 % |
| **FY2026** | 2.348 | +0,2 % | 70,7 % | 539 | 22,9 % | 433 | 18,4 % | 147 | 2,25 | 3,45 | 31 % |

Crecimiento anual compuesto FY2021-FY2026: ingresos **9,4 %**, EBITDA **6,0 %**, BPA **-14,5 %**.




Las ventas crecieron un 9,4 % anual de FY2021 a FY2026, pero en dos fases: +10 %, +18 % y +16 % en FY2022-FY2024 (recuperación de la COVID y adultos creciendo un 10 % al año) y +5 % y 0 % en FY2025-FY2026 [1, 2, 3, 4, 5]. En moneda constante, FY2026 creció un 2 %: los implantes, planos en ingresos con un 5 % más de unidades, porque la mezcla se fue hacia emergentes y gama baja china (el ingreso por implante bajó de 27.677 AUD en FY2024 a 25.316 en FY2026) [1]. El margen EBITDA subyacente cayó 4,6 puntos, al 22,9 %: 1,5 puntos de margen bruto por mezcla, 1,2 por menor absorción de costes fijos al recortar la producción y 0,6 por divisa; la I+D subió un 15 %, al 14 % de las ventas, y la reestructuración y la reposición del bonus sumaron 69 M [1]. Ningún año es incomparable por perímetro: Oticon Medical entró a coste cero y con pérdidas no materiales [3].

### Ajustes y partidas no recurrentes

Cifras reportadas (estatutarias) en la cuenta. La empresa publica un beneficio «subyacente» que excluye partidas significativas: en FY26, 66,0 M después de impuestos de gasto en la nube (94,3 M antes) y 109,1 M de valor razonable, participadas y deterioros de inversiones del fondo de innovación (121,4 M antes; Epiminder 81,5 M de deterioro); en FY25, reexpresado, 22,9 M de nube y 2,7 M de inversiones [1]. Ambas partidas están dentro del EBIT estatutario y van en no_recurrentes_en_ebitda. FY24: integración de Oticon Medical (28,2 M antes de impuestos) [3]. FY20-FY21: litigio de patentes con AMF/Advanced Bionics [5, 16]. La nube se repite de FY22 a FY27 y solo pasó a partida significativa con FY26 (FY25 reexpresado); los 32 M de reestructuración y 37 M de bonus de FY26 se quedan dentro del subyacente [1].

# 6. Resultados recientes

*Confianza: Media*

| Periodo | Ingresos | Crec. interanual | Crec. orgánico | EBITDA | M. EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1S23** | 893 | +9,5 % | +7,0 % | 223 | 25,0 % |
| **2S23** | 1.063 | +28,7 % | +24,0 % | 254 | 23,9 % |
| **1S24** | 1.113 | +24,7 % | +20,0 % | 298 | 26,8 % |
| **2S24** | 1.145 | +7,7 % | – | 291 | 25,4 % |
| **1S25** | 1.170 | +5,1 % | +6,0 % | 319 | 27,3 % |
| **2S25** | 1.186 | +3,6 % | – | 293 | 24,7 % |
| **1S26** | 1.176 | +0,5 % | -2,0 % | 273 | 23,2 % |
| **2S26** | 1.167 | -1,6 % | +6,0 % | 172 | 14,7 % |




## Lo que dijo la dirección en las últimas presentaciones

HY26 (13-feb-2026): ventas 1.176,0 M (+1 % reportado, -2 % en moneda constante), margen bruto 73 % (75 %), EBIT subyacente 254,8 M (-11 %) y beneficio subyacente 194,8 M (-9 %); la dirección situó el beneficio subyacente de FY26 en la parte baja de la guía de 435-460 M, atribuyó la debilidad a un proceso de contratación y registro del sistema Nucleus Nexa más largo de lo previsto y señaló ~10 % de crecimiento interanual de unidades en noviembre-diciembre en mercados clave, con el 80 % de las unidades de diciembre ya Nexa [7]. FY26 (18-ago-2026): ventas +2 % en moneda constante y +6 % en el segundo semestre, beneficio subyacente 322 M en la parte alta de la guía revisada; 69 M de costes de transición en gastos operativos (32 M de reestructuración y 37 M de reposición del bonus) dentro del subyacente; guía FY27 de ventas con crecimiento «low single-digit» en moneda constante y beneficio subyacente de 330-350 M, margen bruto 70-71 %, I+D 13 % de ventas, ~60 M después de impuestos de gasto en la nube como partida significativa y un efecto divisa de ~-10 % sobre el beneficio [6]. No se localizó transcripción de las conferencias (Cochlear no la publica en la ASX); el texto se basa en las presentaciones.

# 7. Balance y capital circulante

| Periodo | Activo total | Fondo com. + intang. | Circulante | Caja | Deuda fin. | Arrend. | Deuda neta | Patrimonio | DN/ EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 2.426 | 386 | 310 | 610 | 45 | 219 | -345 | 1.690 | -0,9x |
| **FY2022** | 2.465 | 393 | 386 | 629 | 43 | 211 | -375 | 1.686 | -0,8x |
| **FY2023** | 2.569 | 444 | 479 | 556 | 0 | 202 | -354 | 1.749 | -0,7x |
| **FY2024** | 2.745 | 451 | 579 | 514 | 0 | 244 | -270 | 1.841 | -0,4x |
| **FY2025** | 2.825 | 501 | 787 | 276 | 0 | 236 | -40 | 1.950 | -0,1x |
| **FY2026** | 2.603 | 483 | 752 | 188 | 0 | 213 | 25 | 1.741 | 0,1x |

| Periodo | Circulante / ventas | Días de cobro | Días de inventario | Días de pago | Ciclo de caja (días) | Liquidez corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 20,7 % | 72 | 192 | 181 | 83 | 3,1x |
| **FY2022** | 23,4 % | 77 | 240 | 206 | 111 | 2,5x |
| **FY2023** | 24,7 % | 82 | 233 | 202 | 113 | 2,4x |
| **FY2024** | 25,9 % | 80 | 254 | 197 | 137 | 2,3x |
| **FY2025** | 33,6 % | 91 | 296 | 177 | 210 | 2,4x |
| **FY2026** | 32,0 % | 83 | 261 | 144 | 200 | 2,1x |

Días de inventario y de pago calculados sobre el coste de ventas.

Cambio de perímetro (FY2024: Oticon Medical (implantes cocleares), consolidada desde el 21-may-2024 por contraprestación nula: entra en balance con poco más de un mes en la cuenta; efecto no material [3].). Los ratios de balance de ese año (días, circulante, deuda neta / EBITDA, ROIC) y los indicadores de calidad contable no son comparables con los anteriores.




Cochlear no tiene deuda financiera: caja de 187,7 M, líneas no dispuestas de 350 M y arrendamientos de 212,7 M [1]. La caja neta bajó de 609,6 M en FY2021 a 187,7 M porque el dividendo (281,2 M en FY2026) superó al flujo libre y porque el circulante se comió 308 M en FY2024-FY2025: existencias de 311,5 M a 499,4 M y clientes de 437,5 M a 585,9 M antes del lanzamiento de Nexa [1, 3]. En FY2026 el circulante bajó al 32,0 % de las ventas (33,6 % en FY2025), lejos aún del 20,7-25,9 % de FY2021-FY2024. Del puente solo se descuentan, además, el dividendo final de 85,0 M pendiente de pago y la provisión de reestructuración de 30,4 M [1].

## 8. Flujos de caja

*Confianza: Alta*

| Periodo | Flujo operativo | Capex | Arrend. | FCF | B. neto | FCF / B. neto | Capex / ventas | Capex / amort. | FCF por acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 265 | 67 | 21 | 178 | 324 | 55 % | 4,5 % | 0,9x | 2,71 |
| **FY2022** | 377 | 77 | 26 | 274 | 289 | 95 % | 4,7 % | 1,1x | 4,16 |
| **FY2023** | 362 | 96 | 31 | 235 | 301 | 78 % | 5,0 % | 1,2x | 3,57 |
| **FY2024** | 389 | 90 | 32 | 267 | 357 | 75 % | 4,0 % | 1,1x | 4,06 |
| **FY2025** | 238 | 103 | 36 | 99 | 389 | 25 % | 4,4 % | 1,1x | 1,51 |
| **FY2026** | 368 | 91 | 36 | 241 | 147 | 164 % | 3,9 % | 0,9x | 3,68 |




Acumulado FY2021-FY2026: FCF **1.294**, conversión **72 %** del beneficio neto; adquisiciones 152, dividendos 1.272, recompras 101.

La conversión del beneficio en caja fue del 72 % acumulado en FY2021-FY2026 (1.294 M de flujo libre), con dos años anómalos por el circulante: FY2025 (98,8 M, 25 %) por la acumulación de existencias y cuentas a cobrar antes de Nexa, y FY2026 (241,1 M, 164 % de un beneficio estatutario deprimido por deterioros no monetarios) por su descarga parcial [1, 2]. El capex es bajo y estable (3,9-5,0 % de las ventas) y la empresa califica el de FY2026 (90,7 M) como de mantenimiento [1]; la inversión en crecimiento va por la cuenta, en I+D (323,2 M) y en el programa en la nube (94,3 M en FY2026), no por el capex. Los impuestos pagados en FY2026 (131,9 M) doblaron al gasto por el calendario de pagos a cuenta [1].

# 9. Calidad contable

*Confianza: Media*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auditor | **KPMG (socia firmante: Rachel Gatt)** | | |
| Opinión del último informe | **Favorable** | Ejercicio analizado | **FY2026** |

| Indicador | Valor | Lectura |
|---|---|---|
| **Altman Z** | 7,99 | Zona segura (> 2,99 seguro; < 1,81 riesgo). No aplica a bancos ni aseguradoras, y subestima la solvencia de empresas con grandes anticipos de clientes o prefinanciación pública (contratistas, construcción), que inflan el pasivo. |
| **Piotroski F** | 6 / 9 | Intermedio (4-6). |
| **Beneish M** | -3,00 | Por debajo de −1,78: sin señal de manipulación. |
| **Flujo operativo / beneficio neto (acumulado)** | 1,11x | El beneficio se cobra. |

| Criterio Piotroski | Cumple |
|---|---|
| **Beneficio neto positivo** | Sí |
| **Flujo operativo positivo** | Sí |
| **ROA mejora** | No |
| **Flujo operativo > beneficio neto** | Sí |
| **Baja el endeudamiento (deuda / activo)** | Sí |
| **Mejora la liquidez corriente** | No |
| **No emite acciones** | Sí |
| **Mejora el margen bruto** | No |
| **Mejora la rotación del activo** | Sí |

## Ajustes, criterios contables y remuneración en acciones

KPMG firma sin salvedades [1]. Los tres indicadores del motor son sanos: Altman Z de 7,99 (zona segura, sin deuda), Piotroski F de 6 sobre 9 (falla en ROA, liquidez, margen bruto) y Beneish M de −3,00, lejos de la zona de manipulación. La I+D se lleva entera a gasto y la remuneración en acciones es pequeña (12,1 M) [1]. Lo que hay que vigilar es el uso del beneficio subyacente: el gasto en la nube existe desde FY2022 (21,6 a 94,3 M al año), pero solo se excluye desde FY2026, con FY2025 reexpresado; eso subió el subyacente de FY2025 de 392 a 414,5 M y suaviza la caída de FY2026 [1, 49]. A favor, la reestructuración (32 M) y el bonus (37 M) se quedan dentro del subyacente [1]. El deterioro de Epiminder (81,5 M) y la caída de Nyxoah reflejan apuestas fuera del negocio principal [1].

### Señales de alerta

| Señal | Nivel | Explicación |
|---|---|---|
| **Partidas significativas recurrentes** | Media | El gasto en la nube se excluye del subyacente desde FY26 (FY25 reexpresado), pero existe desde FY22 (21,6; 38,5; 30,3; 32,7; 94,3 M antes de impuestos) y seguirá en FY27 (~60 M después de impuestos) [1, 3, 4, 5, 6]. |
| **Deterioro de inversiones estratégicas fuera del subyacente** | Media | 121,4 M antes de impuestos en FY26, sobre todo Epiminder (deterioro 81,5 M tras su salida a bolsa); Nyxoah pasa de 64,9 a 14,6 M a valor razonable contra patrimonio [1]. |
| **Costes de reestructuración dentro del subyacente** | Baja | 32 M de reestructuración y 37 M de reposición del bonus en FY26 se quedan en el subyacente (criterio conservador) [1]. |
| **Cambio de criterio en I+D** | Baja | Desde FY26 las subvenciones de I+D se compensan con el gasto (FY25 reexpresado: -10,3 M en I+D y en otros ingresos), sin efecto en el EBIT [1]. |
| **Acumulación y descarga de circulante** | Baja | FY25: existencias +107,8 M y clientes +101,7 M antes de Nexa, flujo operativo 237,6 M; FY26 recupera 368,0 M [1]. |
| **Demanda colectiva por la guía de FY26** | Media | Presentada en sep-2026 tras el recorte de guía del 22-abr-2026; sin provisión (posterior al cierre) [15]. |
| **Provisión de garantías como asunto clave de auditoría** | Baja | 47,5 M; depende de tasas de fallo y coste de reparación de productos nuevos (Nexa) [1]. |

## 10. Rentabilidad sobre el capital

*Confianza: Media*

| Periodo | ROIC | ROE | ROA | Margen neto | Rotación del activo | Apalancamiento | Capital invertido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 21,7 % | 19,2 % | 13,3 % | 21,6 % | 0,62x | 1,44x | 1.344 |
| **FY2022** | 22,4 % | 17,1 % | 11,8 % | 17,5 % | 0,67x | 1,45x | 1.327 |
| **FY2023** | 24,4 % | 17,5 % | 11,9 % | 15,5 % | 0,77x | 1,47x | 1.353 |
| **FY2024** | 26,6 % | 19,9 % | 13,4 % | 16,0 % | 0,84x | 1,48x | 1.483 |
| **FY2025** | 23,9 % | 20,5 % | 14,0 % | 16,6 % | 0,84x | 1,47x | 1.740 |
| **FY2026** | 16,2 % | 8,0 % | 5,4 % | 6,3 % | 0,87x | 1,47x | 1.838 |




**ROIC incremental** (variación del NOPAT sobre variación del capital invertido en el periodo): 1,2 % · **WACC**: 10,5 %.

Cochlear crea valor: el ROIC fue del 21,7-26,6 % en FY2021-FY2025, más del doble del WACC del 10,46 %, y bajó al 16,2 % en FY2026 con la caída del margen [1]. El ROIC lo mueve el margen, no la rotación: el capital invertido (1.838 M, con 266 M de fondo de comercio) crece despacio porque la fabricación es poco intensiva en capital (capex del 3,9 % de las ventas), mientras que el margen EBIT subyacente pasó del 23,6 % al 18,4 % en un año [1]. El ROIC incremental del periodo es de solo el 1,2 %: el capital invertido creció más que el beneficio operativo, sobre todo por el circulante (+308 M en FY2024-FY2025), que entró antes que las ventas de Nexa. Frente a los competidores, la escala es la ventaja: Advanced Bionics tuvo un EBITA normalizado del 6,8 % en su último ejercicio, con 252 M CHF de ventas, menos que la I+D anual de Cochlear [28].

# 11. Deuda y solvencia

*Confianza: Alta*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deuda neta a 30 jun 2026 | **25 M** | Deuda neta / EBITDA últimos 12 m | **0,0x** |
| Pasivos asimilables a deuda (pensiones y otros) | **115 M** | Deuda neta ajustada | **140 M** |
| Deuda neta ajustada / EBITDA | **0,3x** | Liquidez disponible | **Caja 187,7 M y sin deuda financiera a 30-jun-26 (caja neta 187,7 M; 275,7 M un año antes); líneas bancarias multiopción no garantizadas de 350 M sin disponer, más 20 M de avales (10,6 M usados) y otras líneas de 25,1 M (23,9 M usados en avales); deuda comprometida incluidos avales de 370 M con vencimientos de 150 M a 1-2 años, 100 M a 2-3, 20 M a 3-4 y 100 M a 5-6 [1]. En FY26 dispuso y devolvió 185 M dentro del año [1].** |
| Rating | **Sin rating publicado en el informe anual; sin deuda financiera [1]** | | |




## Covenants, pasivos fuera de la deuda y contingencias

Arrendamientos 212,7 M (42,0 corrientes), con la sede de Sídney hasta 2035; intereses de arrendamiento 8,1 M [1]. Provisiones 94,2 M: garantías 47,5 M (asunto clave de auditoría), reestructuración 30,4 M (a usar en 12 meses), retirada del CI500 de 2011 6,3 M, legal y seguros 4,1 M, restitución de locales 5,9 M [1]. Prestaciones a empleados 160,1 M [1]. Pasivos contingentes: reclamaciones de pacientes por el CI500 en EE. UU. cubiertas por seguro, discusiones confidenciales sobre patentes y revisiones fiscales y aduaneras [1]. Demanda colectiva presentada en el Tribunal Supremo de Victoria (anunciada el 29-sep-2026) por la previsión de beneficio de FY26, para compradores entre el 15-ago-2025 y el 21-abr-2026; la empresa la niega [15]. Sin covenants publicados ni pagos aplazados de adquisiciones; 24 M de ingresos diferidos no corrientes por acciones de Epiminder recibidas como pago de un contrato de fabricación [1].

# 12. Asignación de capital

*Confianza: Media*

Dividendo objetivo del 70 % del beneficio subyacente (FY26: 3,45 AUD por acción, -20 %, payout 70 %; dividendo final de 1,30 AUD, franqueado al 85 %) [1]. Recompra progresiva en mercado desde marzo de 2023, complementaria al dividendo, inactiva en FY26 porque la caja neta estaba por debajo del objetivo de ~200 M [1, 6]. Sin deuda; la caja operativa se reinvierte en I+D y crecimiento de mercado y el resto se reparte [1].

| Periodo | FCF | Adquisiciones | Dividendos | Recompras | Ampliaciones | Retorno / B. neto | Acciones (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2021** | 178 | 18 | 76 | 0 | 0 | 23 % | 65,7 |
| **FY2022** | 274 | 62 | 194 | 0 | 0 | 67 % | 65,8 |
| **FY2023** | 235 | 30 | 197 | 30 | 0 | 76 % | 65,9 |
| **FY2024** | 267 | 16 | 246 | 43 | 0 | 81 % | 65,7 |
| **FY2025** | 99 | 13 | 278 | 28 | 0 | 79 % | 65,6 |
| **FY2026** | 241 | 14 | 281 | 0 | 0 | 191 % | 65,5 |




## Historial de adquisiciones

| Año | Objetivo | Importe | Financiación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| **FY2024** | Negocio de implantes cocleares de Oticon Medical (Neurelec S.A.S. y Oticon Medical Maroc), de Demant; ~20.000 pacientes | 0 | Contraprestación nula. El acuerdo original (abr-2022) era por DKK 850 M (~170 M AUD) e incluía la conducción ósea; se redujo tras la revisión de la CMA británica [3, 5]. | Negocio con pérdidas «no materiales»; costes de integración de 28,2 M antes de impuestos en FY24 como partida significativa; ganancia en la combinación pequeña; sin deterioro de fondo de comercio [3]. |
| **FY2021-FY2026** | Fondo de innovación: Nyxoah, Epiminder, Precisis y otros | – | Caja propia (compras de inversiones: 18,4 M FY21, 61,7 M FY22, 29,8 M FY23, 15,9 M FY24, 12,6 M FY25, 13,8 M FY26) [1, 3, 5]. | Ganancias de 30,8 M (FY21) y 12,1 M (FY22) después de impuestos; pérdidas después: 4,6 M FY23, 1,9 M FY24, 2,7 M FY25 y 109,1 M FY26 (deterioro de Epiminder de 81,5 M; 36 % de Epiminder valorado en 25,0 M; Nyxoah 14,6 M) [1, 2, 4, 5]. |

La dirección ha devuelto casi toda la caja: 1.272 M de dividendos y 101 M de recompras en FY2021-FY2026 contra 1.294 M de flujo libre, con un payout del 70 % del subyacente [1]. El problema es que ese dividendo se mantuvo mientras el circulante absorbía caja, y la caja neta cayó de 609,6 M a 187,7 M; las recompras se pararon en FY2026 por quedar por debajo del objetivo de ≈ 200 M [1]. Las compras han sido pequeñas y baratas (Oticon Medical, a precio cero, trajo ≈ 20.000 pacientes cautivos para servicios) [3, 21], pero el fondo de innovación acumula pérdidas de 118 M después de impuestos en FY2023-FY2026, sobre todo por Epiminder [1, 2, 4]. Veredicto: disciplina razonable en las compras, generosidad excesiva en el dividendo en el pico del circulante.

# Parte III — Equipo y gobierno

## 13. Equipo directivo

*Confianza: Alta*

| Nombre | Cargo | Desde | % capital | Trayectoria y resultados |
|---|---|---|---|---|
| **Dig (Diggory) Howitt** | CEO & President y consejero delegado (Managing Director) | 2018 | 0,10 % | En Cochlear desde 2000 (COO, presidente de Asia-Pacífico, SVP de fabricación y logística); antes en Boston Consulting Group y Boral. Presidente desde el 31-jul-2017 y CEO desde el 3-ene-2018 [1]. Con él la guía de beneficio subyacente se cumplió o mejoró en FY21-FY24 y se rebajó en FY25 (390-400 M frente a 410-430 M) y FY26 (290-330 M frente a 435-460 M) [11, 12, 13, 14, 26, 45]. Posee 64.142 acciones (0,10 % del capital) [1]. |
| **Dra. Sarah Thom** | Directora financiera (CFO) | 2025 | 0,00 % | CFO desde enero de 2025 (en el equipo directivo desde el 1-nov-2024), sustituyendo a Stu Sayers; antes socia y directora general de BCG, codirectora de su práctica de salud en Australia y Nueva Zelanda; doctora en astrofísica [1]. Sin acciones a 30-jun-2026 [1]. |
| **Alison Deans** | Presidenta del consejo (no ejecutiva, independiente) | 2021 | 0,01 % | Consejera desde el 1-ene-2015 y presidenta desde el 21-ago-2021; preside la comisión de nombramientos [1]. 4.500 acciones a 30-jun-2026; compró 1.400 más en mercado el 19-ago-2026 a 136,63 AUD (5.900 en total) [1, 46]. |
| **Jan Janssen** | Director de tecnología (CTO) | 2017 | 0,01 % | En Cochlear desde 2000; SVP de I+D desde 2005, CTO desde 2017 y responsable de calidad y regulatorio desde 2019; dirige a más de 600 ingenieros y científicos (Nexa, electrodo con liberación de fármaco, implante totalmente implantable) [1]. 7.299 acciones a 30-jun-2026, tras vender 4.000 en FY26 [1]. |
| **Stu Sayers** | Presidente de Asia-Pacífico y Latinoamérica | 2025 | – | En Cochlear desde 2016; fue presidente de Services y CFO hasta enero de 2025; antes Audible (Amazon) en Asia-Pacífico, E*TRADE, Yahoo!7, ANZ y McKinsey [1]. |
| **Lisa Aubert** | Presidenta de Norteamérica | 2022 | – | En Cochlear desde 1994; presidenta de la región Américas desde abril de 2022, antes vicepresidenta de ventas de Norteamérica; audióloga de formación [1]. Norteamérica es la región donde la cirugía directa al consumidor creció un 10 % en FY26 [1]. |

### ¿Cumple lo que promete?

| Año | Lo que prometió | Lo que logró | Cumplió |
|---|---|---|---|
| **FY2021** | Beneficio neto subyacente de 225-245 M AUD (rango vigente al cierre; FY21 empezó sin guía por el COVID) | 237 M AUD (+54 %) [45] | Sí |
| **FY2022** | 265-285 M AUD (ago-2021) [45] | 277 M AUD, dentro del rango [14] | Sí |
| **FY2023** | 290-305 M AUD (ago-2022), con margen neto de ~18 % antes de la inversión en la nube [14] | 305 M AUD, extremo alto [13] | Sí |
| **FY2024** | 355-375 M AUD (ago-2023), mejorada a 385-400 M el 8-feb-2024 [13, 47] | 387 M AUD (+27 %) [12] | Sí |
| **FY2025** | 410-430 M AUD (ago-2024); «extremo bajo» en feb-2025; rebajada a 390-400 M el 12-jun-2025 [8, 12, 48] | 392 M AUD (+1 %) [11] | No |
| **FY2026** | 435-460 M AUD (ago-2025); «extremo bajo» en feb-2026; recortada a 290-330 M el 22-abr-2026 [7, 11, 26] | 322 M AUD, un 28 % por debajo del punto medio inicial (447,5 M) y en el extremo alto de la guía revisada [49] | No |
| **FY2027** | 330-350 M AUD (ago-2026), con ventas «low single-digit» en moneda constante y AUD/USD de 70 céntimos [49] | Pendiente | – |
| **Medio plazo** | Margen neto subyacente del 18 % (objetivo a largo plazo reiterado desde FY22) [14, 49] | 17-18 % en FY22-FY25; 14 % en FY26 [49] | Parcial |

Dig Howitt lleva 26 años en Cochlear y 8 como CEO; el equipo es estable salvo en finanzas (Sarah Thom sustituyó a Stu Sayers en enero de 2025) [1]. La credibilidad ha caído: la guía se cumplió en FY2021-FY2024, pero en FY2025 se rebajó en junio y en FY2026 el punto medio pasó de 447,5 M en agosto a 310 M en abril, y el subyacente acabó en 322 M [26, 48, 49]. La demanda colectiva nace de ahí [15]. A favor: el consejo dejó al CEO sin bonus en FY2026, el LTI de FY2023 no consolidó y siete consejeros hicieron nueve compras de acciones en los últimos doce meses, por 0,82 M [1, 46, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75]. No hay plan de sucesión público; el CEO tiene un 0,098 % del capital [1].

## 14. Gobierno corporativo

*Confianza: Alta*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consejeros | **9** | Independientes | **89 %** |
| Antigüedad media en el consejo | **5,9 años** | Criterios de buen gobierno cumplidos | **12 de 13 (1 sin dato)** |
| Cambios de presidente o primer ejecutivo (24 meses) | **0** | | |

| Consejero | Cargo | Tipo | Desde | Comisiones |
|---|---|---|---|---|
| **Alison Deans** | Presidenta | Independiente | 2015 | Nombramientos (presidenta) |
| **Dig Howitt** | CEO & President, consejero delegado | Ejecutivo | 2017 | Medical Science; Product and Services Innovation |
| **Prof. Bruce Robinson, AC** | Consejero | Independiente | 2016 | Medical Science (presidente); Auditoría y Riesgos; Nombramientos; Product and Services Innovation |
| **Sir Michael Daniell, KNZM** | Consejero | Independiente | 2020 | Auditoría y Riesgos; Medical Science; Product and Services Innovation; Nombramientos |
| **Christine McLoughlin, AM** | Consejera | Independiente | 2020 | People and Culture (presidenta hasta agosto de 2026); Auditoría y Riesgos; Nombramientos; Product and Services Innovation |
| **Michael del Prado** | Consejero | Independiente | 2022 | Product and Services Innovation (presidente); Medical Science; Nombramientos; People and Culture |
| **Karen Penrose** | Consejera | Independiente | 2022 | Auditoría y Riesgos (presidenta); People and Culture; Nombramientos; Product and Services Innovation |
| **Caroline Clarke** | Consejera | Independiente | 2024 | People and Culture; Nombramientos; Product and Services Innovation |
| **Richard Freudenstein** | Consejero | Independiente | 2025 | People and Culture (presidente desde agosto de 2026); Nombramientos; Product and Services Innovation |

| Criterio | Dato | Resultado |
|---|---|---|
| **Consejeros independientes ≥ 50 % (≥ 33 % si hay accionista de control)** | 89 % | Cumple |
| **Presidencia sin vínculo familiar ni profesional con el accionista de control** | Sin control | Cumple |
| **Presidente no ejecutivo, o consejero coordinador independiente** | No ejecutivo | Cumple |
| **Comisión de auditoría con mayoría de independientes y presidida por uno** | Sí | Cumple |
| **Ningún consejero «otro externo» con más de 12 años** | Ninguno | Cumple |
| **Estabilidad de la cúpula: como mucho un cambio de presidente o primer ejecutivo en 24 meses** | 0 cambios | Cumple |
| **Peor voto en contra sobre remuneración (3 juntas) ≤ 20 %** | 3,5 % en contra | Cumple |
| **Variable a largo plazo ligado a rentabilidad (ROIC, TSR, FCF)** | Sí | Cumple |
| **Una acción, un voto, sin blindajes ni límites de voto estatutarios** | Sí | Cumple |
| **Sin operaciones vinculadas relevantes** | No hay | Cumple |
| **Auditor con 10 años o menos en el cargo** | Sin dato | Sin dato |
| **Opinión de auditoría sin salvedades** | Favorable | Cumple |
| **Directivos compradores netos en 12 meses (o sin ventas relevantes)** | Compras 0,82 / ventas 0,00 M | Cumple |

## Accionariado

| Accionista | % capital | Tipo | Movimientos recientes |
|---|---|---|---|
| **State Street Corporation** | 7,17 % | Gestora / custodio (índices) | 9,33 % → 10,33 % (12-ago-2026) → 9,32 % (24-ago) → 8,27 % (31-ago) → 7,17 % (15-sep-2026) [50, 51, 52, 53] |
| **The Vanguard Group** | 6,01 % | Gestora (índices) | De 5,00 % a 6,01 % el 27-ene-2026; 5,9 % en la lista del informe anual [1, 54] |
| **Bank of New York Mellon (BNY)** | 5,25 % | Custodio / gestora | Entra y sale del 5 % varias veces en abr-jun 2026; 6,26 % (3-sep) → 5,25 % (2-oct-2026) [55, 56] |
| **BlackRock Group** | 5,00 % | Gestora | De 7,68 % (+0,53 % en ADR) el 29-jun-2026 a 5,00 % (+0,59 % en ADR) el 31-ago-2026; 6,7 % en la lista del informe anual [1, 57] |
| **Pinnacle Investment Management Group** | 5,04 % | Gestora | Salió en mar-2026, volvió al 5,04 % el 24-ago, salió el 25-ago y volvió al 5,04 % el 31-ago-2026 [58] |
| **AustralianSuper** | – | Fondo de pensiones | Entró con 5,20 % (3-nov-2025), subió a 7,24 % (3-mar-2026), bajó a 5,02 % el 23-abr-2026 (día siguiente al recorte de guía) y salió el 24-abr-2026 [59, 60, 61] |
| **Autocartera** | – | Autocartera | Recompra inactiva: 0,1 M AUD recomprados en FY26 (28,3 M en FY25); 65.398.917 acciones emitidas; acciones para los planes de empleados compradas en mercado [1, 42] |




## Compras y ventas de consejeros y directivos (12 meses)

| Fecha | Persona | Operación | Acciones | Importe (M) |
|---|---|---|---|---|
| **16 feb 2026** | Richard Freudenstein (consejero) | Compra | 485 | 0,10 |
| **18 feb 2026** | Karen Penrose (consejera) | Compra | 100 | 0,02 |
| **19 feb 2026** | Bruce Robinson (consejero) | Compra | 253 | 0,05 |
| **19 ago 2026** | Alison Deans (presidenta) | Compra | 1.400 | 0,19 |
| **19 ago 2026** | Karen Penrose (consejera) | Compra | 286 | 0,04 |
| **20 ago 2026** | Michael Daniell (consejero) | Compra | 386 | 0,05 |
| **24 ago 2026** | Caroline Clarke (consejera) | Compra | 1.132 | 0,15 |
| **24 ago 2026** | Michael del Prado (consejero) | Compra | 488 | 0,07 |
| **1 sep 2026** | Richard Freudenstein (consejero) | Compra | 1.100 | 0,15 |

## Remuneración

| | | | |
|---|---|---|---|
| Remuneración total del primer ejecutivo (FY2026) | **1,99 M** | Fijo | **2,22 M** |
| Variable anual | **0,31 M** | Variable a largo plazo | **-0,55 M** |
| Peor voto a favor (3 juntas) | **96,5 %** | Peor voto en contra (3 juntas) | **3,5 %** |

El paquete del CEO para FY2027 es de 2,24 M de fijo, un STI objetivo de 2,17 M y un LTI de 2,71 M [42]. El STI de FY2026 pesaba un 65 % en métricas financieras (ventas 50 %, beneficio subyacente 15 %) y un 35 % estratégico; se cumplió al 37 % y el consejo decidió no pagarlo al CEO [1]. El LTI, a cuatro años y sin repetición de pruebas, mide un 50 % el TSR relativo frente al ASX 100 y un 50 % el crecimiento del BPA básico subyacente (del 7,5 % al 12,5 % anual) [1]: premia beneficio, no crecimiento a cualquier precio, aunque sobre el BPA subyacente, cuya definición cambió en FY2026. Hay cláusula de recuperación sobre el STI diferido y el LTI [1]. El voto en contra del informe de remuneración no pasó del 3,53 % en 2023-2025 [39, 40, 41].

## Operaciones vinculadas, estructura de control y defensas

No hay accionista de control: los mayores son gestoras de índices y custodios (State Street 7,17 %, Vanguard 6,01 %, BNY 5,25 %, Pinnacle 5,04 %, BlackRock 5,00 %), con entradas y salidas frecuentes del umbral del 5 % tras el desplome [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58]. Una acción, un voto, sin clases ni límites de voto. La única defensa son las cláusulas de OPA proporcional, renovadas en 2023 con el 99,90 % y que se vuelven a votar el 26-oct-2026 [41, 42]. Ocho de los nueve consejeros son independientes, la presidenta también, y la comisión de auditoría y riesgos es toda independiente [1]. No hay operaciones vinculadas relevantes [1].

## Señales de alerta

- Demanda colectiva de accionistas presentada en el Tribunal Supremo de Victoria por quienes compraron entre el 15-ago-2025 y el 21-abr-2026, por la previsión de beneficio subyacente de FY26 (engaño y deber de información continua, según la prensa); Cochlear niega las acusaciones y se defenderá [15, 62]. La prensa cita al despacho Echo Law; no consta financiador [62].
- Rotación del CFO en los últimos 24 meses: Sarah Thom sustituyó a Stu Sayers en enero de 2025 [1].
- Dos guías anuales seguidas rebajadas (jun-2025 y abr-2026); la de abril de 2026 bajó el punto medio de 447,5 M a 310 M [26, 48].
- Reestructuración en el cuarto trimestre de FY26: 32 M AUD de costes de reestructuración por cambios organizativos, dentro de 69 M de costes de transición [1].
- Nuevo premio de retención por objetivos para la alta dirección en FY27 (no para el CEO), aparte de los incentivos ordinarios; detalles en el informe de remuneración de FY27 [1].
- Posiciones cortas muy volátiles: 2,6 % (1-oct-2025), 5,8 % (16-abr-2026), 9,3 % (1-jul-2026), 9,2 % (25-ago-2026) y 2,2 % (1-sep y 2-oct-2026) [63].

# Parte IV — Mercado y valoración

## 15. Previsiones de la compañía y consenso

*Confianza: Media*

Guía de FY27 publicada con los resultados del 18-ago-2026: ventas con crecimiento «low single-digit» en moneda constante y beneficio neto subyacente de 330-350 M AUD (322,4 M en FY26), con mejora gradual de los implantes en mercados desarrollados, disciplina de costes e inversión selectiva [49]. Supuestos: I+D en torno al 13 % de las ventas; el programa cloud termina en FY27 con unos 60 M después de impuestos, fuera del subyacente; AUD/USD 0,70 y AUD/EUR 0,61, que restan ~10 % al beneficio subyacente frente a los tipos medios de FY26; capex de 100-110 M; aranceles sin cambios [49]. A medio plazo, margen neto de vuelta al 18 % (14 % en FY26) [49]. Dividendo: payout objetivo del 70 % del subyacente [49]. La guía de FY26 se recortó el 22-abr-2026; la de FY27 no se ha cambiado hasta la fecha de corte.

| Periodo | Ingresos | EBITDA | EBIT | BPA | DPA | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2027e** | 2.367 | 556 | 455 | 4,41 | 3,60 | MarketScreener, 16 analistas, 8-oct-2026 [82] |
| **FY2028e** | 2.500 | 604 | 499 | 5,67 | 3,98 | MarketScreener, 16 analistas, 8-oct-2026 [82] |
| **FY2029e** | 2.673 | 671 | 559 | 6,34 | 4,47 | MarketScreener, 16 analistas, 8-oct-2026 [82] |

### Nuestra proyección frente al consenso

| Periodo | Ingresos propios | Ingresos consenso | Dif. | EBITDA propio | EBITDA consenso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2027e** | 2.359 | 2.367 | -0,3 % | 477 | 556 | -14,1 % |
| **FY2028e** | 2.489 | 2.500 | -0,4 % | 610 | 604 | +1,0 % |
| **FY2029e** | 2.651 | 2.673 | -0,8 % | 671 | 671 | 0,0 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Analistas | **16** | Comprar / mantener / vender | **0 / 14 / 2** |
| Precio objetivo medio | **137,09** | Rango de precios objetivo | **110,00 – 165,00** |

### Revisiones de estimaciones

El consenso se ha hundido con el precio: el beneficio subyacente de FY2026 se esperaba en 435-460 M en agosto de 2025 (guía) y salió en 322 M [49]. Las recomendaciones pasaron de 4 compras fuertes, 3 compras y 7 mantener en mayo de 2026 a 0 compras, 14 mantener y 2 ventas en octubre [84]; Jefferies bajó a mantener el 23-jul-2026 con precio objetivo de 128,40 [83]. Para FY2027 el consenso de EBIT (454,6 M) cuadra con el punto medio de la guía; su BPA (4,414) es estatutario e incluye la nube, frente a un BPA subyacente de 5,19 según Stock Analysis [82, 84]. No hemos encontrado gratis la serie de revisiones a 3 y 12 meses.

## 16. Comportamiento en bolsa

*Confianza: Alta*

Rentabilidad de precio (sin dividendos).

| Periodo | Acción | Índice | Sector |
|---|---|---|---|
| **En el año** | -50,3 % | +0,2 % | -4,1 % |
| **1 año** | -55,3 % | -2,5 % | -16,0 % |
| **3 años (anual.)** | -20,3 % | +7,9 % | -4,6 % |
| **5 años (anual.)** | -10,1 % | +3,6 % | -6,2 % |
| **10 años (anual.)** | -0,9 % | +4,8 % | +4,1 % |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Beta (5 años, mensual) | **0,89** | Volatilidad anualizada (1 año) | **64,1 %** |
| Máxima caída (5 años) | **-73,2 %** | Posiciones cortas | **2,2 %** |

La acción ha caído un 55,3 % en un año y un 50,3 % en 2026, frente a una subida del 0,2 % del S&P/ASX 200 en el año y una caída del 4,1 % de su índice de salud [78]. La caída se concentra en dos días: −18,9 % el 13-feb-2026 (resultados del semestre, guía en la parte baja) y −40,7 % el 22-abr-2026 (recorte de la guía de 435-460 M a 290-330 M) [26, 78]. Desde el mínimo de 88,74 del 30-abr la acción ha rebotado un 45 % [78]. La posición corta llegó al 9,3 % del capital en julio y ha bajado al 2,16 % el 2-oct-2026 [63]: la apuesta bajista se ha cerrado. La caída máxima en cinco años es del 73,2 % [78].

## 17. Múltiplos frente a su historia

*Confianza: Media*

| Múltiplo | Actual | Mediana | Mínimo | Máximo | Percentil | Prima / descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EV/EBITDA últimos 12 meses (cierre de cada año)** | 15,8x | 29,6x | 14,9x | 40,2x | 17 % | -47 % |
| **PER últimos 12 meses (cierre de cada año)** | 57,4x | 50,9x | 45,2x | 61,2x | 83 % | +13 % |




Con el precio de cierre de cada ejercicio, Cochlear cotizó de media a 29,6 veces el EBITDA de los últimos doce meses en FY2021-FY2026; hoy está a 15,8 veces, un 47 % por debajo y en el percentil 17. El PER de los últimos doce meses (57,4 veces) no es comparable porque usa el beneficio estatutario de FY2026, hundido por los deterioros; sobre el subyacente (4,93 AUD) es de 26 veces, frente a 45-61 veces en el pasado. El cambio es estructural: el mercado pagaba un crecimiento del 10 % de los adultos que ha desaparecido en dos años, y con un bono australiano al 5,34 % [81] el múltiplo de una empresa de crecimiento medio es más bajo. El descuento frente a la historia no es, por sí solo, una razón para comprar.

## 18. Comparables cotizados

*Confianza: Media*

Tres fabricantes de audífonos y soluciones auditivas que compiten con Cochlear en el paciente con pérdida auditiva (Sonova, dueña de Advanced Bionics; Demant; GN Store Nord), dos fabricantes australasiáticos de dispositivos médicos con ejercicio no natural y venta global (ResMed, Fisher & Paykel Healthcare) y tres líderes de tecnología médica con producto implantable o de nicho y márgenes altos (Straumann, Intuitive Surgical, Edwards Lifesciences). MED-EL, el segundo fabricante de implantes cocleares, no cotiza.

| Empresa | País | Capitaliz. | EV/Vtas | EV/ EBITDA LTM | EV/ EBITDA NTM | PER NTM | Crec. | M. EBITDA | ROIC | DN/ EBITDA | FCF yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cochlear** | AU | 8.437 | 3,6x | 15,8x | 15,0x | 27,1x | +1,9 % | 22,9 % | 16,2 % | 0,0x | 2,9 % |
| **Sonova** | CH | 25.901 | 4,4x | 17,1x | 14,3x | 22,5x | +7,0 % | 26,0 % | – | 1,1x | 4,0 % |
| **Demant** | DK | 14.611 | 3,5x | 15,1x | 13,0x | 21,4x | +9,7 % | 23,3 % | – | 3,3x | 4,2 % |
| **GN Store Nord** | DK | 3.288 | – | – | – | – | – | 13,8 % | – | – | 11,5 % |
| **ResMed** | US | 47.159 | 5,7x | 13,7x | 13,9x | 19,0x | +3,4 % | 41,2 % | – | -0,3x | 5,0 % |
| **Fisher & Paykel Healthcare** | NZ | 22.412 | 11,9x | 34,5x | 28,1x | 46,4x | +11,4 % | 34,4 % | – | -0,5x | 1,8 % |
| **Straumann** | CH | 24.189 | 5,2x | 16,7x | 14,9x | 24,5x | +8,7 % | 30,6 % | – | -0,2x | 2,8 % |
| **Intuitive Surgical** | US | 211.356 | 13,1x | 29,6x | 25,1x | 40,2x | +14,2 % | 43,5 % | – | -0,7x | 2,3 % |
| **Edwards Lifesciences** | US | 69.930 | 7,0x | 22,9x | 19,4x | 27,1x | +10,5 % | 29,7 % | – | -1,9x | 2,2 % |

La primera fila es la empresa analizada (calculada con sus propios datos). Los estadísticos excluyen a la empresa.

| Estadístico | EV/Vtas | EV/EBITDA LTM | EV/EBITDA NTM | PER NTM | Crec. | M. EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mediana** | 5,7x | 17,1x | 14,9x | 24,5x | +9,7 % | 30,2 % |
| **Media** | 7,3x | 21,4x | 18,4x | 28,7x | +9,3 % | 30,3 % |
| **Percentil 25** | 4,8x | 15,9x | 14,1x | 22,0x | +7,9 % | 25,3 % |
| **Percentil 75** | 9,4x | 26,3x | 22,3x | 33,7x | +11,0 % | 36,1 % |

## Valor implícito por acción

| Múltiplo aplicado | Métrica de la empresa | Múltiplo p25 / mediana / p75 | Valor p25 | Valor mediana | Valor p75 | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EV/EBITDA próximos 12 meses** | 569 | 14,1x / 14,9x / 22,3x | 121,29 | 128,25 | 192,17 | -0,6 % |
| **EV/EBITDA últimos 12 meses** | 539 | 15,9x / 17,1x / 26,3x | 129,60 | 139,48 | 214,84 | +8,1 % |
| **PER próximos 12 meses** | 4,8 | 21,9x / 24,5x / 33,7x | 104,42 | 116,56 | 160,09 | -9,6 % |
| **EV/Ventas últimos 12 meses** | 2.348 | 4,8x / 5,7x / 9,4x | 170,78 | 201,47 | 337,70 | +56,2 % |




**Regresión EV/EBITDA NTM sobre crecimiento** (7 comparables): múltiplo = 6,5 + 1,28 × crecimiento; $R^2$ = 0,53. Para el crecimiento esperado de la empresa (1,9 %), el múltiplo ajustado es 8,9x y el valor por acción, 76,06.

Cochlear cotiza a 15,0 veces el EBITDA de los próximos 12 meses, en la mediana de los comparables (14,9 veces) y en el grupo de Sonova (14,3), ResMed (13,9) y Straumann (14,9) [87, 90, 92]. Con un crecimiento esperado inferior (el consenso da un 0,8 % en FY2027 en AUD) y un margen EBITDA más bajo (22,9 % frente a una mediana del 30,2 %), no hay descuento que justifique una compra. Intuitive, Fisher & Paykel y Edwards cotizan a 19-28 veces porque crecen un 10-14 % [91, 93, 94]. El PER de 27,1 veces de Cochlear usa el BPA estatutario del consenso, con la nube dentro; sobre el subyacente es de unas 25 veces, en la mediana. Usaríamos el EV/EBITDA de los próximos 12 meses (128,25 por acción), con poco peso.

# 19. Transacciones precedentes

*Confianza: Media*

| Fecha | Objetivo | Comprador | EV (M) | EV/ Ventas | Prima | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2021-05** | Sennheiser Consumer Division (auriculares y hearables) | Sonova | 322 | 0,80x | – | Precio 200 M EUR por un negocio con ventas de unos 250 M EUR anuales; EBITDA no publicado [95]. |
| **2021-10** | SteelSeries (periféricos y auriculares de juego) | GN Store Nord | 1.724 | 3,68x | – | Valor empresa 8.000 M DKK; ventas pro forma de 2020 2.175 M DKK y margen EBITA ajustado del 13,3 % (≈27,7x EBITA, cálculo propio); EBITDA no publicado [96]. |
| **2022-04** | Oticon Medical (implantes cocleares y de conducción ósea de Demant) | Cochlear | 170 | 2,19x | – | Anunciada por 850 M DKK (≈170 M AUD) con 75-80 M AUD de ventas y pérdidas [17]; tras las objeciones de la CMA británica se cerró en mayo de 2024 solo el negocio de implantes cocleares, a precio cero [21]. |
| **2024-01** | Axonics (neuromodulación sacra implantable) | Boston Scientific | 4.897 | 9,29x | – | 71 USD por acción en efectivo: 3.700 M USD de valor de las acciones y unos 3.400 M de valor empresa; ventas esperadas de 2023 de unos 366 M USD (+34 %) [97]. Prima no publicada en el comunicado. |
| **2025-02** | Nevro (estimulación medular implantable) | Globus Medical | – | – | 17 % | 5,85 USD por acción, valor de las acciones de unos 250 M USD; prima del 17 % sobre el cierre del 5-feb-2025 (27 % sobre la media de 90 días); ventas preliminares de 2024 de 408-409 M USD; valor empresa no publicado [98]. Empresa en dificultades. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor por acción implícito (mediana de EV/ventas) | **130,75** | Rango p25 – p75 | **79,06 – 231,44** |

No hay transacciones de control útiles: MED-EL es privada y familiar, Advanced Bionics pertenece a Sonova desde 2009, y la única operación del sector, la venta de Oticon Medical por Demant, acabó a precio cero tras años de pérdidas [17, 21]. Las demás (Sennheiser, SteelSeries, Axonics, Nevro) son de negocios cercanos sin múltiplo de EBITDA publicado. Cochlear podría interesar a un gran grupo de tecnología médica a estos precios (8.437 M de capitalización), pero no hay accionista que pueda vender el control, y la ley australiana exige una oferta a todos; las cláusulas de OPA proporcional se renuevan en la junta de octubre [42].

# 20. Descuento de flujos de caja (DCF)

*Confianza: Media*

## Supuestos y su justificación

**Crecimiento de ingresos.**

FY2027e crece un 0,5 % en AUD: la guía pide crecimiento de un dígito bajo en moneda constante y el dólar australiano a 0,70 USD y 0,61 EUR resta unos 3,5 puntos [1, 49]; el consenso da un 0,8 % [82]. Después, 5,5 % en FY2028e y 6,5 % en FY2029e, en línea con el consenso (5,6 % y 6,9 %) [82], y un máximo del 7 % en FY2030e-FY2031e, por debajo del 9,4 % anual de FY2021-FY2026 y del 7,3 % de los diez años desde FY2016 [1, 16]. Se descuenta menos que la historia por tres razones medidas: los implantes de desarrollados crecieron solo un 1 % en FY2026, China pierde precio con la compra centralizada (licitación con precios un 75 % más bajos) y el ciclo de procesadores de reemplazo madura en FY2027 [1, 32].

**Márgenes.**

El margen EBITDA subyacente fue del 26,6-29,0 % en FY2022-FY2025 y del 22,9 % en FY2026 [1]. FY2027e lleva el 23,8 % que implica la guía de 330-350 M de beneficio subyacente menos los ≈ 86 M antes de impuestos del último año del programa en la nube (60 M después de impuestos), que es caja aunque la empresa lo deje fuera del subyacente: 20,2 % [1]. Después sube hasta el 27 % en FY2032e, por debajo del objetivo de la empresa (margen neto del 18 %, que equivale a un EBITDA de ≈ 28,5 %) porque la empresa ha fallado ese objetivo dos años seguidos y la I+D sube al 13 % de las ventas [1, 49].

**Inversión y circulante.**

Capex del 6,0 % de las ventas en FY2027e (guía de 100-110 M, 4,4 %, más ≈ 1,5 % de altas de derechos de uso por NIIF 16) y del 5,2-5,6 % después, frente al 3,9-5,0 % más 1,4-1,6 % de arrendamientos de FY2021-FY2026 [1]. La amortización, el 4,6 % (4,5 % en FY2026). El circulante pasa del 32,0 % de las ventas de FY2026 al 29 %: la empresa está deshaciendo el exceso de existencias del lanzamiento de Nexa (−13 % en el segundo semestre) y el histórico de FY2021-FY2024 fue del 20,7-25,9 % [1, 6]. Tipo impositivo del 25,5 % (25 % subyacente en FY2025 y FY2026) [1].

**Coste del capital.**

Sin deuda financiera, el WACC es el coste de los fondos propios: tasa libre del 5,34 % (bono australiano a 10 años, RBA, 30-sep-2026) [81], beta de 0,93 y prima de mercado del 5,5 %: 10,46 %. La beta es la ajustada mensual a cinco años frente al S&P/ASX 200 (0,89 sin ajustar; 1,00 semanal a dos años) [78]. Frente a sanidad mundial (iShares Global Healthcare) sale 0,60-0,73 y frente a tecnología médica de EE. UU. (iShares U.S. Medical Devices) 0,57-0,71 [78], pero esas betas miden el riesgo frente al sector, no frente al mercado del inversor en AUD, y llevan dentro el tipo de cambio AUD/USD. Con la prima implícita del mercado (4,2 %) el coste de capital es del 9,25 %.

**Valor terminal.**

Crecimiento a perpetuidad del 3,0 % en AUD: inflación objetivo del banco central australiano del 2-3 % más un crecimiento real modesto, dentro del rango coherente con una tasa libre del 5,34 % (por debajo del 4,84 %). El múltiplo implícito del valor terminal es de 7,9 veces el EBITDA, frente a 13-15 veces de los comparables de tecnología médica hoy [87, 88, 89, 90, 91, 92]: es conservador, pero llega tras veinte años de proyección, con el crecimiento ya en el 3 %. El valor terminal pesa un 29 % y la etapa de transición otro 29 %.

## Coste medio ponderado del capital

| Componente | Valor |
|---|---|
| Tasa libre de riesgo | 5,34 % |
| Beta | 0,93 |
| Prima de riesgo de mercado | 5,50 % |
| Prima adicional (país, tamaño, específica) | 0,00 % |
| Coste de los fondos propios | 10,46 % |
| Coste de la deuda antes de impuestos | 5,50 % |
| Tipo impositivo | 25,50 % |
| Coste de la deuda después de impuestos | 4,10 % |
| Peso de la deuda (D / (D + E)) | 0,00 % |
| WACC | 10,46 % |
| Prima de riesgo implícita del mercado (regla relativa) | 4,20 % |
| WACC con la prima implícita del mercado | 9,25 % |

## Proyección

| Año | Ingresos | Crec. | EBITDA | M. EBITDA | Amort. | Impuestos | Capex | Δ Circ. | FCFF | Fracción | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027e | 2.359 | 0,5 % | 477 | 20,2 % | 109 | 94 | 142 | -21 | 262 | 0,73 | 183 |
| FY2028e | 2.489 | 5,5 % | 610 | 24,5 % | 114 | 126 | 139 | 28 | 316 | 1,00 | 280 |
| FY2029e | 2.651 | 6,5 % | 671 | 25,3 % | 122 | 140 | 143 | 36 | 352 | 1,00 | 281 |
| FY2030e | 2.836 | 7,0 % | 737 | 26,0 % | 130 | 155 | 150 | 41 | 391 | 1,00 | 283 |
| FY2031e | 3.035 | 7,0 % | 804 | 26,5 % | 140 | 169 | 161 | 43 | 431 | 1,00 | 283 |
| FY2032e | 3.232 | 6,5 % | 873 | 27,0 % | 149 | 185 | 168 | 57 | 463 | 1,00 | 275 |
| FY2033e | 3.426 | 6,0 % | 925 | 27,0 % | 158 | 196 | 178 | 56 | 495 | 1,00 | 266 |
| FY2034e | 3.615 | 5,5 % | 976 | 27,0 % | 166 | 206 | 188 | 55 | 527 | 1,00 | 257 |
| FY2035e | 3.795 | 5,0 % | 1.025 | 27,0 % | 175 | 217 | 197 | 52 | 558 | 1,00 | 246 |
| FY2036e | 3.985 | 5,0 % | 1.076 | 27,0 % | 183 | 228 | 207 | 55 | 586 | 1,00 | 234 |

FCFF = EBIT × (1 − t) + amortizaciones − capex − variación del circulante. «Fracción» es la parte del ejercicio que queda por delante desde la fecha de valoración; VA, el valor actual.




## Etapa de transición (DCF en tres etapas)

Con la etapa de transición de 10 años el DCF da 92,21 por acción; sin ella (crecimiento terminal desde FY2036e), 85,32.

| Año | Ingresos | Crec. | M. EBITDA | Capex | FCFF | Factor | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2037e** | 4.176 | 4,8 % | 27,0 % | 216 | 617 | 0,362 | 223 |
| **FY2038e** | 4.369 | 4,6 % | 27,0 % | 225 | 649 | 0,327 | 213 |
| **FY2039e** | 4.561 | 4,4 % | 27,0 % | 234 | 681 | 0,297 | 202 |
| **FY2040e** | 4.752 | 4,2 % | 27,0 % | 243 | 714 | 0,268 | 192 |
| **FY2041e** | 4.942 | 4,0 % | 27,0 % | 251 | 746 | 0,243 | 181 |
| **FY2042e** | 5.130 | 3,8 % | 27,0 % | 259 | 778 | 0,220 | 171 |
| **FY2043e** | 5.315 | 3,6 % | 27,0 % | 267 | 810 | 0,199 | 161 |
| **FY2044e** | 5.496 | 3,4 % | 27,0 % | 275 | 842 | 0,180 | 152 |
| **FY2045e** | 5.672 | 3,2 % | 27,0 % | 283 | 874 | 0,163 | 143 |
| **FY2046e** | 5.842 | 3,0 % | 27,0 % | 290 | 904 | 0,148 | 134 |

Entre la proyección explícita y el valor terminal, el crecimiento baja en línea recta hasta el terminal; el margen y los ratios son los del último año explícito, y la inversión neta (capex − amortización) se reduce en proporción al crecimiento.

### Por qué el crecimiento dura más allá de la proyección.

El crecimiento de Cochlear dura más que los diez años explícitos porque el mercado está casi sin penetrar: en los adultos y mayores de los países desarrollados, más de 6 millones de candidatos, solo se implanta en torno al 3 % [1], y en niños de países emergentes menos del 10 % [1]. El ROIC fue del 21,7-26,6 % en FY2021-FY2025 y del 16,2 % en FY2026, por encima del WACC del 10,46 % [1]. La ventaja se sostiene en costes de cambio de por vida: cada implantado solo puede usar procesadores de Cochlear, y los servicios ya son el 27 % de las ventas [1]. La etapa de transición lleva el crecimiento del 5 % de FY2036e al 3 % terminal en diez años, sin subir el margen; aporta un 8,1 % del valor.

## Valor terminal

| Concepto | Valor |
|---|---|
| **Método principal** | Crecimiento a perpetuidad |
| **Crecimiento a perpetuidad** | 3,0 % |
| **Múltiplo EV/EBITDA de salida** | 15,0x |
| **Valor terminal (Gordon)** | 12.497 |
| **Valor terminal (múltiplo)** | 23.659 |
| **Múltiplo de salida implícito en Gordon** | 7,9x |
| **Crecimiento implícito en el múltiplo** | 6,39 % |
| **Peso del valor terminal en el valor empresa** | 29 % |

## Del valor empresa al valor por acción

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Valor actual de los flujos proyectados | 2.589 |
| Valor actual de la etapa de transición (10 años) | 1.772 |
| Valor actual del valor terminal | 1.758 |
| Valor empresa | 6.119 |
| − Deuda financiera neta (con arrendamientos) | -25 |
| − Minoritarios, pensiones y otros; + asociadas | -63 |
| Valor de los fondos propios | 6.031 |
| Acciones diluidas (millones) | 65,4 |
| Valor por acción | 92,21 |



## Sensibilidad: WACC × Crecimiento a perpetuidad

| WACC | 2,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,5 % | 4,0 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 % | 101,64 | 104,59 | 108,00 | 111,96 | 116,64 |
| 10,0 % | 94,37 | 96,78 | 99,52 | 102,68 | 106,36 |
| 10,5 % | 88,00 | 89,98 | 92,21 | 94,76 | 97,70 |
| 11,0 % | 82,38 | 84,02 | 85,85 | 87,93 | 90,30 |
| 11,5 % | 77,39 | 78,75 | 80,27 | 81,98 | 83,91 |

## Sensibilidad: margen EBITDA × crecimiento de ingresos (desplazamiento de toda la proyección)

| Margen \ crec. | -2 pp | -1 pp | 0 pp | +1 pp | +2 pp |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 pp | 69,15 | 75,59 | 82,67 | 90,49 | 99,18 |
| -1 pp | 73,11 | 79,94 | 87,44 | 95,74 | 104,97 |
| 0 pp | 77,07 | 84,28 | 92,21 | 101,00 | 110,75 |
| +1 pp | 81,02 | 88,62 | 96,99 | 106,25 | 116,54 |
| +2 pp | 84,98 | 92,97 | 101,76 | 111,50 | 122,32 |

## ¿Puede la empresa sostener el crecimiento previsto?

**Veredicto: Sí.**

| Prueba | Valor |
|---|---|
| Crecimiento medio de ingresos proyectado | 5,5 % |
| Capex bruto medio (incluidas compras si van como inversión) | 5,4 % de las ventas |
| Reinversión neta acumulada (capex − amortización + circulante) | 629 M (13 % del NOPAT) |

La proyección apenas necesita inversión neta de la amortización (reinversión acumulada de 629 M, el 13 % del NOPAT, con un capex bruto medio del 5,4 % de las ventas). En un negocio de activos ligeros, el crecimiento medio del 5,5 % tiene que salir de subir precios y de ganar volumen sin capital nuevo, y la prueba es el poder de precios y la cuota; en

un comprador en serie, la amortización es de intangibles comprados y la prueba es el capex bruto (las compras) frente al crecimiento comprado.

| Año | Volumen | Precio | Otros (mezcla, compras) | Crecimiento | De dónde sale |
|---|---|---|---|---|---|
| **FY2027e** | +3,0 % | +1,0 % | -3,5 % | +0,5 % | Guía de crecimiento de un dígito bajo en moneda constante: unidades al +3 % (+5 % en FY2026) y precio +1 % (Nexa +3 % en desarrollados, China y emergentes a la baja); el dólar australiano a 0,70 USD resta ≈ 3,5 puntos (reparto entre volumen y precio, estimación propia) [1, 32, 49]. |
| **FY2028e** | +4,5 % | +1,0 % | 0,0 % | +5,5 % | Consenso del +5,6 % [82]; unidades por debajo del +5-16 % anual de FY2022-FY2026 por la madurez del ciclo de procesadores y la compra centralizada china [1]. |
| **FY2029e** | +5,0 % | +1,5 % | 0,0 % | +6,5 % | Consenso del +6,9 % [82]; el volumen depende de la derivación de adultos (penetración del ≈ 3 %) y el precio, de las indicaciones nuevas en desarrollados [1, 24]. |

Sí. El foso son los costes de cambio: cada implantado compra procesadores de Cochlear de por vida (servicios, el 27 % de las ventas) y Nexa subió el precio un 3 % en desarrollados [1]. El base crece un 5,5 % anual, menos que el 7,3 % de FY2016-FY2026 y que el 7,6 % previsto para el mercado [1, 16, 27]. El motor ve una reinversión de activos ligeros (13 % del NOPAT) porque el circulante baja del 32 % al 29 %; aun así, cada AUD de ventas nuevas pide 0,38 de capital, dentro del 0,19-0,58 de FY2021-FY2026, y el margen del NOPAT final (16,7 %) queda bajo el 17-18 % de FY2022-FY2025. Cuota: los implantes, al ritmo del grupo, pasarían del ≈ 50 % al ≈ 40 % del mercado de 2035 [27]. El riesgo es el volumen de adultos y el precio en China: está en el bajista.

## DCF inverso: qué descuenta el precio actual

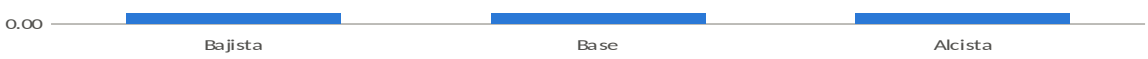
| | |
|---|---|
| Crecimiento anual implícito en el precio (FY2027e-FY2036e) | **9,1 % (base: 5,5 %)** |
| Margen EBITDA final implícito | **34,7 % (base: 27,0 %)** |
| Rentabilidad anual implícita (TIR al precio actual) | **8,5 % (WACC: 10,5 %)** |

El DCF da 92,21 AUD por acción, un 28,5 % por debajo del precio de 129,00, con un WACC del 10,46 %; sin la etapa de transición, 85,32. Con la prima implícita del mercado (WACC del 9,25 %) sube a 111,95, todavía un 13 % por debajo. El DCF inverso es la clave: con nuestros márgenes, el precio exige un crecimiento del 9,1 % anual durante diez años, frente al 5,5 % de nuestra base, al 4,4 % anual del consenso hasta FY2029 [82] y al 7,3 % anual de los diez años hasta FY2026 [1, 16]; o, con nuestro crecimiento, un margen EBITDA del 34,7 %, que Cochlear no ha tenido nunca (máximo del 29,0 % en FY2022). La rentabilidad anual implícita en el precio es del 8,5 %, por debajo del 10,46 % de coste de capital y del 9,25 % que pide hoy el mercado. Tras caer un 55 % en un año, la acción ya no descuenta la Cochlear de antes de 2025 (con un PER de 50 veces), pero sí una vuelta completa al crecimiento de dos dígitos de los adultos, que la empresa no ha demostrado desde el primer semestre de FY2025. La sensibilidad es alta: cada medio punto de WACC mueve el valor un 7-8 %.

## 21. Escenarios

*Confianza: Media*

| Escenario | Prob. | Crec. medio | Margen final | WACC | Valor | Potencial | Qué tiene que ocurrir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bajista** | 25 % | 3,5 % | 24,0 % | 10,5 % | 63,90 | -50,5 % | Los implantes de adultos en desarrollados siguen como en FY2026 (+1 % en moneda constante) porque la derivación depende del canal de audífonos y de la capacidad hospitalaria; China repite recortes de precio y Advanced Bionics o MED-EL ganan cuota con precio. Es lo que ya pasó en FY2026: ventas −1 % reportadas y margen EBITDA −4,6 puntos [1]. |
| **Base** | 50 % | 5,5 % | 27,0 % | 10,5 % | 92,21 | -28,5 % | La guía de FY2027 se cumple (330-350 M de beneficio subyacente), la medicalización de la pérdida auditiva devuelve los adultos a crecer un 5-8 % y el margen vuelve hacia el 27 % de EBITDA en cinco años, algo por debajo del objetivo de la empresa. |
| **Alcista** | 25 % | 8,0 % | 28,5 % | 10,5 % | 125,14 | -3,0 % | Las vías de derivación médica funcionan como en los hospitales privados australianos (+15 % en FY2026) [1], el implante totalmente implantable y el electrodo con fármaco salen antes de 2030 y el grupo vuelve a crecer un 8-9 % anual, con el margen neto del 18 % del objetivo [1, 49]. |




**Valor ponderado por probabilidad:** 93,37 AUD (-27,6 %).

La asimetría es desfavorable con nuestro coste de capital: el alcista (125,14) queda un 3,0 % por debajo del precio y el bajista (63,90) un 50,5 %, de modo que el precio ya descuenta algo mejor que nuestro caso alcista. Con la prima del mercado mejora (alcista 154,18 y bajista 75,97, asimetría de 0,47), pero sigue sin compensar. El bajista no es cosmético: es FY2026 repetido, un año en que la empresa recortó su guía un 31 % en el punto medio en dos meses [26]. Para que la asimetría cambie, el precio tendría que bajar de 98,66 (comprar) o tendría que aparecer evidencia de que los adultos vuelven a crecer a dos dígitos.

## 22. Suma de partes

*Confianza: Alta*

No aplica: implantes, servicios y soluciones acústicas son un mismo negocio con los mismos clientes (cirujanos y audiólogos), la misma red comercial y márgenes que la empresa no separa por línea; los servicios dependen de la base de implantados. Los segmentos que publica son regiones, no negocios con comparables distintos [1].

## 23. Síntesis de valoración

*Confianza: Media*



| Método | Mínimo | Central | Máximo |
|---|---|---|---|
| **Cotización 52 semanas** | 88,74 | 129,00 | 296,50 |
| **Precio objetivo de los analistas** | 110,00 | 137,09 | 165,00 |
| **Comparables: EV/EBITDA NTM** | 121,29 | 128,25 | 192,17 |
| **Comparables: PER NTM** | 104,42 | 116,56 | 160,09 |
| **Transacciones precedentes (EV/ventas)** | 79,06 | 130,75 | 231,44 |
| **DCF (WACC y g ± 0,5)** | 84,02 | 92,21 | 102,68 |
| **Escenarios (bajista – alcista)** | 63,90 | 93,37 | 125,14 |
| **DCF con la prima del mercado** | 102,91 | 111,95 | 122,62 |
| **Precio actual** | 128,35 | 129,00 | 129,64 |

| Método | Valor por acción | Potencial | Peso |
|---|---|---|---|
| **DCF** | 92,21 | -28,5 % | 40 % |
| **Comparables (mediana EV/EBITDA y PER)** | 122,41 | -5,1 % | 25 % |
| **Transacciones precedentes (no se usa)** | 130,75 | +1,4 % | 0 % |
| **Escenarios ponderados** | 93,37 | -27,6 % | 35 % |

**Valor intrínseco ponderado (largo plazo):** 100,16 AUD (-22,4 % sobre 129,00).

El DCF pesa un 40 % porque Cochlear es un negocio estable, sin deuda y con una base de clientes cautiva, donde lo que importa es cuánto y durante cuánto tiempo crece. Los escenarios pesan un 35 % porque la duda principal (si los adultos vuelven a crecer) es binaria. Los comparables, un 25 %: la mediana del EV/EBITDA de los próximos 12 meses (14,9 veces) da 128,25 AUD y la del PER 116,56 (122,41 de media), cerca del precio, pero la muestra es frágil (de 14,6 a 17,1 veces según cuál se quite) y ninguno es un fabricante de implantes cocleares puro. Las transacciones no pesan: no hay ninguna compra de un fabricante de implantes cocleares con múltiplo publicado, y la única del sector, Oticon Medical, se cerró a precio cero [21]. La dispersión es amplia (DCF de 92,21 frente a comparables de 128,25) y dice lo mismo que el DCF inverso: el mercado valora a Cochlear como a una empresa de tecnología médica media, y el flujo de caja solo lo sostiene si vuelve a crecer como antes.

## Objetivo a 12 meses: nuestro PER × nuestro BPA

| Escenario | BPA | PER | De dónde sale el PER | Precio | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bajista** | 4,51 | 24,7x | mínimo de 5 años | 111,40 | -11,0 % |
| **Base** | 5,60 | 25,2x | PER actual | 141,12 | +12,1 % |
| **Alcista** | 6,32 | 32,7x | techo de base × 1.3 | 206,66 | +62,9 % |

**Objetivo a 12 meses (ponderado):** 150,07 AUD · rentabilidad +19,0 % (base +12,1 %) · señal Mantener.

**Frente al consenso (solo contraste).**

Nuestro BPA base de FY2028e (5,60) se separa un -1,1 % del consenso (5,67) y nuestro precio base (141,12) un +2,9 % del objetivo medio de los analistas (137,09). No se acerca la cifra: el porqué (ventas, margen, base de BPA o múltiplo) está en el contraste con el consenso de revision-12m-2026-10-13.md.

**Del valor intrínseco al objetivo a 12 meses.**

Valor intrínseco 100,16 (-22,4 %) frente al objetivo a 12 meses ponderado 150,07 (+19,0 % con dividendo; base +12,1 %). La distancia pasa del 25 %: la tesis del valor intrínseco es a más de un año.

# Parte V — Tesis, riesgos y seguimiento

## 24. Catalizadores

*Confianza: Media*

| Fecha | Evento | Qué se sabrá | Prob. | Sentido |
|---|---|---|---|---|
| **26-oct-2026** | Junta general: voto del informe de remuneración, concesión del LTI de FY2027 al CEO y reelección de dos consejeros | Un voto en contra de la remuneración por encima del 25 % sería el primer «strike» de la ley australiana; en 2023-2025 no pasó del 3,53 % [39, 40, 41, 42] | Media | +/− |
| **13-nov-2026** | Capital Markets Day en Sídney | Primer objetivo a medio plazo tras dos guías fallidas: crecimiento de los adultos, margen y calendario del implante totalmente implantable y del electrodo con fármaco [100] | Alta | +/− |
| **Noviembre de 2026** | Tarifas definitivas de Medicare para 2027 (hospitales ambulatorios) | Fija el pago de la cirugía (33.686 USD por la APC 5166 en 2026) y de los procesadores de reemplazo en EE. UU. [33] | Alta | +/− |
| **Febrero de 2027** | Resultados del primer semestre de FY2027 | Primera prueba de la guía de 330-350 M: crecimiento de implantes en desarrollados y margen bruto del 70-71 % [1] | Alta | +/− |
| **2026-2027** | Demanda colectiva de accionistas en Victoria por la guía de FY2026 | Sin provisión; un acuerdo costaría caja y reputación de la dirección [15, 62] | Media | – |
| **Primer semestre de FY2027** | Lanzamiento del procesador Osia 3 (aprobado por la FDA y con marcado CE) | Recupera las soluciones acústicas tras la pérdida de cuota en EE. UU. y Reino Unido [1] | Alta | + |
| **2027-2028** | Resultados de los ensayos del electrodo con fármaco y del implante totalmente implantable | Dos ensayos del electrodo con reclutamiento completo y dos del implante en marcha [26]; MED-EL ya hizo en Europa las primeras operaciones con un implante totalmente implantable [37] | Media | +/− |

# 25. Riesgos y pre-mortem

*Confianza: Media*

| # | Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto | Efecto en valor | Mitigante | Señal de alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Los adultos de los países desarrollados no vuelven a crecer: la derivación depende del canal de audífonos y de la capacidad hospitalaria** | Mercado | Media | Alto | −31 % (escenario bajista frente a la base) | Programas de derivación directa a profesionales en EE. UU., Alemania, Reino Unido y Australia; publicidad directa al paciente (+10 % en EE. UU.) [1] | Crecimiento en moneda constante de los implantes en desarrollados por debajo del 3 % en el primer semestre de FY2027 |
| 2 | **Precio en China y en emergentes: compra centralizada y recortes del reembolso en las zonas de acceso especial** | Regulatorio | Alta | Medio | −5 % a −8 % (−1 punto de margen en todos los años) | Gama de productos por niveles y fábrica en Chengdu, que llega al equilibrio en FY2027 [1] | Margen bruto por debajo del 70 % o caída de ventas en China en FY2027 |
| 3 | **Divisa: más del 95 % de los ingresos fuera del AUD; un AUD fuerte resta ~10 % al beneficio de FY2027** | Financiero | Media | Medio | −5 % por cada 5 % de apreciación sostenida del AUD (estimación propia) | Coberturas a plazo, que suavizan pero no evitan [1] | AUD/USD por encima de 0,72 |
| 4 | **Credibilidad de la dirección: dos guías anuales recortadas y una demanda colectiva** | Gobierno | Media | Medio | −10 % (prima de riesgo de 0,7 puntos más) | Guía de FY2027 más baja y con supuestos explícitos; consejo mayoritariamente independiente [1, 49] | Nuevo cambio de guía antes de febrero de 2027 |
| 5 | **Competencia tecnológica: MED-EL con implante totalmente implantable, Advanced Bionics con precio para recuperar cuota** | Competencia | Media | Alto | −10 % a −15 % (un punto menos de crecimiento y de margen) | Nexa, único implante con firmware actualizable; 2.300 patentes; I+D de 323 M [1] | Pérdida de cuota en Alemania o EE. UU. en las presentaciones semestrales |
| 6 | **Calidad del producto: una retirada de implantes como la del CI500 en 2011** | Operativo | Baja | Alto | −15 % a −25 % (un año como el bajista y provisiones) | Fiabilidad acumulada del 99,76 % a siete años del Profile Plus [1]; provisión de garantías de 47,5 M [1] | Comunicaciones de seguridad de la FDA o de la TGA sobre Nexa |
| 7 | **Reembolso en EE. UU. y Europa: presión de Medicare y listas de espera en sistemas públicos** | Regulatorio | Media | Medio | −5 % | Evidencia clínica sobre demencia y caídas; guías clínicas en 25 países [1] | Tarifa definitiva de 2027 de la APC 5166 por debajo de la de 2026 |
| 8 | **Inversiones del fondo de innovación con pérdidas (Epiminder, Nyxoah)** | Asignación de capital | Media | Bajo | −1 % (52,6 M en el puente) | Importes pequeños frente a la capitalización [1] | Nuevas compras de participaciones fuera del negocio principal |

## Pre-mortem

Es octubre de 2029 y la acción ha perdido un 40 %, hasta unos 77 AUD. La historia más probable empieza en el Capital Markets Day de noviembre de 2026: la dirección presenta un objetivo de crecimiento de los adultos que el mercado se

cree y la acción rebota. Pero en febrero de 2027 los implantes de desarrollados crecen un 2 % en moneda constante: los audífonos de venta libre y la falta de audiólogos siguen sin derivar candidatos, y las listas de espera del Reino Unido no bajan. China entra en la sexta ronda de compras centralizadas y el margen bruto se queda en el 69 %. El AUD sube a 0,74 USD. En agosto de 2027 el beneficio subyacente se queda en 320 M, por debajo de la guía, y la empresa vuelve a prometer el 18 % de margen neto «a medio plazo». MED-EL presenta resultados del implante totalmente implantable antes que Cochlear y gana concursos en Europa. El mercado deja de pagar 15 veces el EBITDA y pasa a 11 veces, el nivel de una empresa de tecnología médica que crece un 3-4 %. El indicador que lo habría anticipado es el crecimiento en moneda constante de los implantes en desarrollados de cada semestre: por debajo del 3 % dos semestres seguidos, la tesis de la recuperación está rota.

## 26. ESG y controversias

*Confianza: Media*

| Proveedor | Calificación | Fecha |
|---|---|---|
| **MSCI ESG** | AAA (sector de equipos y suministros sanitarios) | 2026-08 |

### Asuntos materiales

Lo que más mueve las cifras es la calidad y seguridad del producto: un implante falla dentro del paciente, y la retirada del CI500 en 2011 aún genera demandas cubiertas por el seguro [1]; la fiabilidad acumulada del Profile Plus es del 99,76 % a siete años [1]. El segundo es el acceso y la asequibilidad, porque el reembolso y la compra pública fijan volumen y precio (China −75 % [32]) [1]. El tercero, la privacidad de datos y la ciberseguridad, crecientes con implantes conectados como Nexa [1]. El clima pesa poco: Cochlear se compromete a cero emisiones netas de alcance 1 y 2 en 2030 y en toda la cadena en 2050, y dice ir en camino [1].

### Controversias

El 29-sep-2026 se presentó una demanda colectiva en el Tribunal Supremo de Victoria por la previsión de beneficio de FY26, en nombre de quienes compraron entre el 15-ago-2025 y el 21-abr-2026; Cochlear lo niega y se defenderá [15]. Siguen las demandas de pacientes por los CI500 retirados en 2011, cubiertas por el seguro [1]. Hay reclamaciones de patentes de competidores que Cochlear no espera que tengan un efecto adverso significativo [1]. En 2023 la CMA bloqueó parte de la compra de Oticon Medical [19].

# 27. Preguntas abiertas para la dirección y la due diligence

*Confianza: Media*

| # | Tema | Pregunta | Por qué importa |
|---|---|---|---|
| 1 | **Adultos en desarrollados** | ¿Qué crecimiento de implantes de adultos en EE. UU. y Europa occidental necesita la guía de FY2027, y qué parte de las derivaciones viene ya del canal médico (hoy el 40 % en EE. UU.)? | Es la variable que separa el bajista de la base: el precio descuenta un 9,1 % anual de crecimiento del grupo. |
| 2 | **Margen** | ¿Qué hace falta para volver al 18 % de margen neto: precio de Nexa, coste de fabricación o gasto comercial? ¿En qué año? | La base lleva el EBITDA al 27 %, por debajo del objetivo; cada punto de margen vale unos 5 AUD por acción. |
| 3 | **China** | ¿Qué parte de las ventas de implantes viene de China y qué precio medio queda tras la licitación nacional y el recorte de las zonas de acceso especial? | El recorte del 75 % del precio en la licitación y la mezcla hacia gama baja ya restaron 1,5 puntos de margen bruto en FY2026. |
| 4 | **Servicios** | ¿Cuánto cae el crecimiento de servicios cuando madure el ciclo del Nucleus 8 y del Kanso 3, y cuál es la tasa de cambio de procesador por implantado y año? | Los servicios (27 % de las ventas) crecieron un 13 % en desarrollados; la guía ya avisa de que crecerán menos. |
| 5 | **Implante totalmente implantable** | ¿Cuándo esperan la aprobación del implante totalmente implantable y del electrodo con fármaco, y a qué precio frente al sistema actual? | Es la tecnología que puede sostener la cuota frente a MED-EL, que ya ha operado en Europa con el suyo. |
| 6 | **Demanda colectiva** | ¿Qué información tenía el consejo entre agosto de 2025 y abril de 2026 sobre las derivaciones en EE. UU., y está asegurada la contingencia? | No hay provisión; un acuerdo y el daño a la credibilidad pesan sobre la prima de riesgo. |
| 7 | **Caja y recompras** | ¿Se reactivan las recompras cuando la caja neta supere los 200 M, o la prioridad es mantener el dividendo con un payout del 70 %? | Con el dividendo de 3,45 AUD y la caja neta en 188 M, el margen para devolver más caja es pequeño. |

# Anexos

## A. Controles de calidad del análisis

18 de 21 controles correctos y 1 explicados. Fuentes: 102 (78 primarias); citas distintas en el texto: 98.

| Control | Resultado | Detalle |
|---|---|---|
| **Geografías suman 100 %** | OK | – |
| **DCF inverso calculable** | OK | – |
| **Puente de ingresos (volumen + precio + otros) = crecimiento del DCF** | OK | – |
| **Circulante del primer año de proyección ≈ último real** | OK | Supuesto 31,0 % frente a 32,0 % real: genera una variación de circulante de -21 M en el primer año. Converge de forma gradual. |
| **Peso del valor terminal ≤ 80 % del valor empresa** | OK | 29 %. |
| **Etapa de transición justificada (ROIC ≥ WACC + 5 puntos)** | OK | ROIC 16,2 % frente a WACC 10,5 %: |
| **Crecimiento a perpetuidad ≤ 3 %** | OK | 3,00 %. |
| **Probabilidades de los escenarios suman 100** | OK | – |
| **Al menos 5 comparables** | OK | 8 comparables. |
| **Comparables estables al quitar una empresa** | Explicado | La mediana del EV/EBITDA NTM va de 14,6x a 17,1x según qué comparable se quite (125,64 a 147,82 por acción): la muestra es frágil; explícalo y no le des mucho peso. Explicación: La mediana del EV/EBITDA NTM depende de si entran Intuitive, Fisher & Paykel y Edwards, que crecen y ganan más que Cochlear. El núcleo comparable (Sonova, Demant, ResMed y Straumann) cotiza a 13-15 veces, alrededor de la mediana de 14,9 veces que se usa; por eso los comparables pesan solo un 25 %. |
| **Pesos de la síntesis suman 100** | OK | – |
| **Múltiplos del objetivo a 12 m según la regla común** | OK | – |
| **Objetivo 12 m frente al consenso** | OK | El base se separa un 2,9 % del objetivo medio de los analistas: explícalo en diferencia_consenso (nunca se acerca la cifra). |
| **Precio del cierre de la fecha de corte (o de las dos sesiones anteriores)** | OK | – |
| **Historia del PER en la misma base que el actual (regla v3)** | Revisar | per_historico no lleva base: "adelantado" (precio de cierre ÷ BPA del año siguiente): el motor aplica la regla v2 antigua, sesgada contra las empresas baratas. En un informe nuevo, rellena la historia adelantada. |
| **Recomendación coherente con la regla de decisión** | Revisar | La regla da «Mantener» y el análisis recomienda «Vender»: hace falta «justificacion_recomendacion». |
| **La síntesis explica la convicción** | OK | La síntesis debe decir por qué tiene esa convicción y qué la subiría o la bajaría. |
| **Al menos 25 fuentes** | OK | 102 fuentes (78 primarias). |
| **Al menos 10 fuentes primarias** | OK | 78. |
| **Toda cita [n] existe en fuentes** | OK | – |
| **Fuentes sin citar ≤ 15 %** | OK | Sin citar: 9, 10, 101, 102. |

| Tipo de fuente | Número |
|---|---|
| **Primaria** | 78 |
| **Sectorial** | 2 |
| **Prensa** | 4 |
| **Datos de mercado** | 18 |

## B. Información no disponible

Cuando un dato no aparece tras tres búsquedas distintas, el análisis lo deja fuera en lugar de estimarlo sin base. Las secciones de núcleo que faltan se avisan también en el resumen.

| Sección no incluida | Tipo |
|---|---|
| **28. Sentimiento en foros y comentarios** | Complemento |

| Sección | Dato que falta | Tipo | Las tres búsquedas | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| **financieros** | cuenta FY2017-FY2020 completa | Complemento | 1) Informe anual FY26: solo gráficos plurianuales; 2) resúmenes quinquenales de remuneración de FY20-FY25: ventas, EBIT, beneficio, BPA y DPA; 3) informe anual FY20 descargado, sin tiempo para extraer costes y balance | Omitido (titulares FY16-FY20 en financieros.extra) |
| **trimestres** | vs_consenso y bpa semestral | Complemento | 1) Presentaciones semestrales: no dan BPA ni consenso; 2) informes semestrales (Appendix 4D) no descargados; 3) consenso previo no accesible en documentos de la empresa | Omitido |
| **trimestres** | transcripción de las conferencias HY26 y FY26 | Complemento | 1) Lista de anuncios de la ASX: sin transcripción; 2) presentaciones HY26 y FY26 leídas; 3) búsqueda web no hecha para no gastar el cupo compartido | Omitido (ultima_presentacion con las presentaciones) |
| **trimestres** | crecimiento en moneda constante de 2S24 y 2S25 | Complemento | 1) Presentaciones FY24 y FY25: crecimiento por línea y semestre en gráficos, no total; 2) informes anuales: solo ejercicio; 3) no derivable sin tipos | Omitido |
| **calidad** | anios_auditor | Complemento | 1) Informe anual FY26 (informe de auditoría y de gobierno): no dice desde cuándo; 2) informes FY22-FY25: KPMG en todos; 3) informe FY20: KPMG | Omitido (KPMG al menos desde FY20) |
| **negocio** | ventas por país (EE. UU.) | Complemento | 1) Nota de segmentos FY26: solo regiones y Australia <4 %; 2) presentación FY26: crecimientos, no importes; 3) informe FY25: igual | Omitido |
| **competencia** | competidores[MED-EL].ingresos y margen_ebit_pct | Núcleo | 1) web corporativa medel.com (About MED-EL): solo empleados y países, sin cifras; 2) búsquedas en alemán e inglés de Umsatz/revenue y prensa austriaca (trend.at): sin cifra publicada; 3) agregadores (Datanyze, InfobelPRO) dan 553-716 M USD sin documento original: no fiables | Omitido |
| **competencia** | competidores[Nurotron, Listent, Impilo].ingresos | Complemento | 1) resultados de la licitación de la NHSA (gov.cn) y prensa china (Yicai): sin ventas por empresa; 2) notas de Demant sobre la venta a Impilo: sin ventas ni resultado de Oticon Medical; 3) búsqueda de cuotas de los fabricantes chinos: sin dato primario | Omitido |

| Sección | Dato que falta | Tipo | Las tres búsquedas | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| **competencia** | competidores[].cuota_pct | Núcleo | 1) informe anual de Cochlear: solo su propia cuota (>60 %); 2) Sonova: no publica cuota de AB; 3) GMI: solo la cuota de Cochlear (49,5 %) y la de los cinco primeros (87 %) | Omitido |
| **competencia** | Medtronic (Sophono) en conducción ósea | Complemento | 1) informes de Cochlear y nota de la ACCC: no la nombran; 2) búsqueda web: sin tiempo de búsquedas disponible tras priorizar AB, MED-EL y China; 3) no se pudo derivar | Omitido |
| **sector** | regulacion: propuesta CMS 2027 para APC 5166 y tarifa de procesadores de reemplazo (L8619) | Complemento | 1) búsqueda de la regla propuesta CY2027 OPPS (CMS-1850-P): solo la actualización general; 2) comentarios de la AAO-HNS a la propuesta 2027: no tratan la APC 5166; 3) guía de codificación de Cochlear: códigos sin importes | Omitido |
| **esg** | calificaciones Sustainalytics, ISS y CDP | Complemento | 1) informe anual FY26: solo cita MSCI AAA; 2) página de Sustainalytics de la empresa: WebFetch devuelve la página genérica del producto, sin la puntuación; 3) búsqueda de CDP e ISS: sin documento original (los buscadores dan 26,8-28,3 de Sustainalytics sin fuente abierta) | Omitido |
| **sector** | serie (más de dos años de tamaño de mercado) | Complemento | 1) informe anual y Capital Markets Day de Cochlear: dan penetración, no tamaño en dinero; 2) Sonova: no da tamaño del mercado de implantes; 3) informes de mercado (GMI, Towards Healthcare, Fortune): solo un año base y el de previsión, y discrepan entre sí (2.000-2.900 M USD en 2025) | Omitido |
| **sector** | regulacion: reembolso europeo (NICE en Reino Unido, Alemania) a la fecha de corte | Complemento | 1) informe anual FY26: solo dice que el Reino Unido amplió el criterio a pérdida severa y que hubo listas de espera y menor cuota en Alemania; 2) Capital Markets Day 2023: topes de financiación en Europa sin detalle por país; 3) búsquedas web reservadas a competencia y Medicare por el límite compartido | Omitido |
| **sector** | ciclo: comportamiento en 2008-09 y 2022 | Complemento | 1) informe anual FY22: historia FY18-FY22 sin 2008-09; 2) anuncios de la ASX disponibles desde 2022; 3) no hay serie anterior a FY2018 en las fuentes leídas | Omitido |
| **gobierno** | remuneracion_ceo.ratio_salario_medio | Complemento | 1) informe anual FY26: no publica el gasto de personal total en las notas ni la ratio CEO/empleado medio; 2) grep de «employee benefits expense», «salaries», «personnel» en el .txt: solo pasivos por empleados y la plantilla (>5.400 personas); 3) Appendix 4G y aviso de junta: no la publican | Omitido |
| **gobierno** | insiders (importe de Michael del Prado) | Complemento | 1) Appendix 3Y: 488 acciones compradas en el mercado OTC de EE. UU. a 96,00 y 96,75 USD (47.157 USD); 2) sin tipo de cambio AUD/USD del día en las notas; 3) convertido con la relación entre el precio en USD y el precio en la ASX del mismo día (138,78 AUD el 20-ago-2026, Appendix 3Y de Caroline Clarke): ~0,692 USD por AUD | Calculado y marcado como estimación |

| Sección | Dato que falta | Tipo | Las tres búsquedas | Decisión |
|---|---|---|---|---|
| **gobierno** | Corporate Governance Statement (cumplimiento de las recomendaciones de la ASX) | Complemento | 1) Appendix 4G FY26 descargado: las casillas marcadas salen ilegibles en el texto; 2) el CGS remite a las págs. 80-90 del informe anual, leídas en parte (comisiones y presidencias); 3) no se miró la imagen de las casillas por tiempo | Omitido |
| **gobierno** | alertas (despacho y financiador de la demanda colectiva) | Complemento | 1) comunicado de la ASX del 29-sep-2026: no los nombra; 2) Grafa (29-sep-2026): no los nombra; 3) Motley Fool (29-sep-2026): cita a Echo Law como despacho que da detalles; no consta financiador | Omitido |
| **comparables** | roic_pct | Complemento | 1) MarketScreener (finances): no publica ROIC, solo ROE y ROA; 2) Stock Analysis: una página por empresa, fuera del presupuesto de llamadas; 3) cálculo propio: requiere balances de ocho empresas | Omitido |
| **multiplos_historicos** | ev_ebitda_ntm / per_ntm históricos | Complemento | 1) MarketScreener (finances): solo múltiplos del año en curso y los dos siguientes; 2) Stock Analysis: series históricas LTM, no NTM; 3) cálculo propio: no hay consenso histórico gratuito por fecha | Omitido |
| **identificacion** | capitalizacion_publicada | Complemento | 1) MarketScreener (finances, consensus): la página resumida no la devuelve; 2) Yahoo chart API: no trae capitalización; 3) cálculo: 129,00 × 65,4 M = 8.437 M AUD (no es una cifra publicada, no se usa como control) | Omitido |
| **consenso** | revisiones a 3 y 12 meses de BPA y EBITDA | Complemento | 1) MarketScreener, pestaña de consenso (solo el último dato); 2) Stock Analysis (recomendaciones de mayo y octubre, sin serie de estimaciones); 3) Investing y MarketIndex (de pago o sin histórico) | Omitido |

## Fuentes

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Report 2026 | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072vl3mz6g9cps.pdf |
| 2 | Annual Report 2025 (incl. Sustainability reporting) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250815/pdf/06mwwc8bndj71z.pdf |
| 3 | Annual Report 2024 (incl. Sustainability reporting) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240815/pdf/066mmnxwsg85ht.pdf |
| 4 | Annual Report 2023 (incl. Sustainability reporting) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230815/pdf/05smklwlw4lr8v.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022 Annual Report | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 19 ago 2022 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20220819/pdf/45d0n6bd83hlwn.pdf |
| 6 | FY26 Result - Presentation | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072vp99h99kr7s.pdf |
| 7 | HY26 Result - Presentation Slides | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 13 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260213/pdf/06w84pssmn1nrr.pdf |
| 8 | HY25 Result - Presentation Slides | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 14 feb 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250214/pdf/06fhn08cgb0jq0.pdf |
| 9 | HY24 Result - Presentation Slides | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 19 feb 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240219/pdf/060hyfs2xbts97.pdf |
| 10 | HY23 Result - Presentation Slides | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 feb 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230215/pdf/45lm744wcm7lk0.pdf |
| 11 | FY25 Result - Presentation | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250815/pdf/06mwwkjvv19z8r.pdf |
| 12 | FY24 Result - Presentation | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240815/pdf/066mmw2ndj8d96.pdf |
| 13 | FY23 Result - Presentation | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 15 ago 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230815/pdf/05smkszvd2k41v.pdf |
| 14 | FY22 Result Presentation | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 19 ago 2022 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20220819/pdf/45d0nhgbql1pd2.pdf |
| 15 | Defence of Class Action Proceedings | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 29 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260929/pdf/074mzsqwdc44r8.pdf |
| 16 | 2020 Annual Report | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 ago 2020 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20200818/pdf/44llkcbscnb9gs.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Cochlear agrees to acquire Oticon Medical, Demant's hearing implants business | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 abr 2022 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20220427/pdf/458chhjpvcq1dh.pdf |
| 18 | UK CMA Phase 1 decision on Cochlear's proposed Oticon Medical acquisition | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 7 dic 2022 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20221207/pdf/45jjp92s4ndv6r.pdf |
| 19 | Final report from the UK CMA and update on the proposed acquisition of Oticon Medical | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 22 jun 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230622/pdf/05qx23qnjb468s.pdf |
| 20 | ACCC will not oppose revised Cochlear, Oticon Medical transaction (media release) | ACCC (vía ASX) | Primaria | 4 abr 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240404/pdf/06254bj8wlwspn.pdf |
| 21 | Cochlear acquires Demant's cochlear implant business | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 21 may 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240521/pdf/063s8hj145lbj9.pdf |
| 22 | Cochlear statement on US tariff announcement | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 8 abr 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250408/pdf/06hhk9qdmm242x.pdf |
| 23 | Cochlear statement on US tariff announcement (Section 301) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 24 jul 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260724/pdf/0720kdnzgg6547.pdf |
| 24 | Capital Markets Day Presentation 2023 | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 oct 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20231027/pdf/05wkp40dzg3007.pdf |
| 25 | Sonova delivers strong FY 2025/26 results (Group Media & Investor Release) | Sonova Holding AG | Primaria | 18 may 2026 | https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/5c27e438-ea7c-11e8-902f-2c44fd856d8c/d66487e1-283c-494c-96e8-abde08681b32/aa588ce5-5e5b-42ae-b45d-8120f62cde75/Sonova_FY25-26+Results_EN.pdf |
| 26 | Trading update and reduction to FY26 earnings guidance | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 22 abr 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260422/pdf/06yqjm0ttfryc1.pdf |
| 27 | Cochlear Implants Market Size, Share & Forecast 2025-2035 | Global Market Insights | Sectorial | ago 2026 | https://www.gminsights.com/industry-analysis/cochlear-implant-systems-market |
| 28 | Annual Report 2025/26 – Financial review (Cochlear Implants segment) | Sonova Holding AG | Primaria | 18 may 2026 | https://report.sonova.com/2026/en/financial-review |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Demant to sell Oticon Medical to Impilo (company announcement 2025-11) | Demant A/S (vía MFN) | Primaria | 22 oct 2025 | https://mfn.se/nir/a/demant/demant-a-s-demant-to-sell-oticon-medical-to-impilo-581858c9 |
| 30 | Investor news – Demant completes divestment of Oticon Medical | Demant A/S (vía MFN) | Primaria | 31 mar 2026 | https://mfn.se/nir/a/demant/demant-a-s-investor-news-demant-completes-divestment-of-oticon-medical-e1df8abc |
| 31 | China's latest bulk procurement of medical consumables brings hope to many (Xinhua, datos de la NHSA) | Gobierno de China (english.www.gov.cn) | Primaria | 20 dic 2024 | https://english.www.gov.cn/news/202412/20/content_WS6764c234c6d0868f4e8ee23e.html |
| 32 | Cochlear Implant Prices Drop 75% in China's Fifth Round of Medical Device Bulk-Buying | Yicai Global | Prensa | 20 dic 2024 | https://www.yicaiglobal.com/news/chinas-fifth-bulk-buying-round-slashes-cochlear-implant-prices-by-75 |
| 33 | CMS Releases CY 2026 HOPPS/ASC Final Rule (tabla de APC de otorrinolaringología) | American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery | Sectorial | 3 dic 2025 | https://www.entnet.org/news/cms-releases-cy-2026-hopps-asc-final-rule/ |
| 34 | Cochlear implant coding and billing guide (CAM-HE-010) | Cochlear Limited | Primaria | 2025 | https://assets.cochlear.com/api/public/content/CAM-HE-010_G |
| 35 | Euro foreign exchange reference rates (histórico: AUD, CHF, USD, DKK) | Banco Central Europeo | Datos de mercado | 7 oct 2026 | https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip |
| 36 | About MED-EL | MED-EL | Primaria | oct 2026 | https://www.medel.com/about-medel |
| 37 | MED-EL: Erste Operationen überhaupt in Europa mit einem vollständig implantierbaren Cochlea-Implantat (nota de prensa) | HearingTracker | Prensa | 19 oct 2020 | https://www.hearingtracker.com/de/press-releases/med-el-first-surgeries-ever-in-europe-with-a-totally-implantable-cochlear-implant |
| 38 | Med-El: Androsch-Preis für eine Ausnahmekönnerin | trend. | Prensa | 10 dic 2025 | https://www.trend.at/unternehmen/med-el-hohe-auszeichnung-fuer-ingeborg-hochmair |
| 39 | Results of 2025 Annual General Meeting | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 23 oct 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251023/pdf/06qy5ykjjjyt00.pdf |
| 40 | Results of 2024 Annual General Meeting | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 oct 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20241025/pdf/069kt5x2p8jdgw.pdf |
| 41 | Results of 2023 Annual General Meeting | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 17 oct 2023 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20231017/pdf/05w4w746lf2wvd.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Notice of Annual General Meeting 2026 & Proxy/Voting Form | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 22 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260922/pdf/074cm6xp6968nl.pdf |
| 43 | Appendix 3Y - Richard Freudenstein (feb-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260218/pdf/06wf8qh14c6nqg.pdf |
| 44 | Appointment of Prof. Ian Meredith to the Cochlear Board | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260918/pdf/074750d6x55740.pdf |
| 45 | FY21 Result - ASX & Media Release | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 20 ago 2021 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20210820/pdf/44zhs9c9ybskff.pdf |
| 46 | Appendix 3Y - Alison Deans | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260825/pdf/0735918wnd3xq8.pdf |
| 47 | Cochlear Upgrades FY24 Earnings Guidance | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 8 feb 2024 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240208/pdf/06069pxgqg0gp0.pdf |
| 48 | Cochlear provides update to FY25 earnings guidance | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 12 jun 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250612/pdf/06knk3vzyxygf4.pdf |
| 49 | FY26 Result - ASX & Media Release | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 18 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260818/pdf/072vlb13j40ckk.pdf |
| 50 | Change in substantial holding - State Street (12-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 14 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260814/pdf/072s38z48rshy3.pdf |
| 51 | Change in substantial holding - State Street (24-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 26 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260826/pdf/0738kht2mgn4x0.pdf |
| 52 | Change in substantial holding - State Street (31-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 2 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260902/pdf/073n5z92v53qy5.pdf |
| 53 | Change in substantial holding - State Street (15-sep-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 17 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260917/pdf/0746pj7nr6ksq7.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Change in substantial holding - Vanguard Group | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 2 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260202/pdf/06vv5qd2pjm3ht.pdf |
| 55 | Change in substantial holding - BNY (3-sep-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 7 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260907/pdf/073sfrq844smkl.pdf |
| 56 | Change in substantial holding - BNY (2-oct-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 6 oct 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20261006/pdf/074z30j8rhty61.pdf |
| 57 | Change in substantial holding - BlackRock Group (31-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 2 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260902/pdf/073lyxgn582rvr.pdf |
| 58 | Becoming a substantial holder - Pinnacle Investment Management (31-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 3 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260903/pdf/073pmls6pmfvj3.pdf |
| 59 | Becoming a substantial holder - AustralianSuper | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 5 nov 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251105/pdf/06rk6cy59qqs2n.pdf |
| 60 | Change in substantial holding - AustralianSuper (23-abr-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 abr 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260427/pdf/06ywxxwcbjcktn.pdf |
| 61 | Ceasing to be a substantial holder - AustralianSuper | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 28 abr 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260428/pdf/06yyf0qfnhds2h.pdf |
| 62 | Cochlear shares fall as investors face another setback | The Motley Fool Australia | Prensa | 29 sep 2026 | https://www.fool.com.au/2026/09/29/cochlear-shares-fall-as-investors-face-another-setback/ |
| 63 | Short position reports (agregado diario), archivos RR20251001, RR20260416, RR20260701, RR20260825, RR20260901 y RR20261002 | ASIC | Primaria | 2 oct 2026 | https://download.asic.gov.au/short-selling/RR20261002-001-SSDailyAggShortPos.csv |
| 64 | Appendix 3Y - Diggory Howitt (ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260825/pdf/073586fl5n1r2h.pdf |
| 65 | Appointment and retirement of Non-executive Director | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 28 jul 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20250728/pdf/06m5z5cx9gxslf.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Change in substantial holding - Citigroup (3-sep-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 3 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260903/pdf/073pr9cc0qv4xh.pdf |
| 67 | Change in substantial holding - JPMorgan Chase (11-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 14 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260814/pdf/072r3jwq8666k0.pdf |
| 68 | Becoming a substantial holder - UBS Group (31-ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 3 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260903/pdf/073njs6yws71c5.pdf |
| 69 | Appendix 3Y - Karen Penrose (feb-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 20 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260220/pdf/06wj9syfb3g0b5.pdf |
| 70 | Appendix 3Y - Bruce Robinson | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260227/pdf/06wwff7v4sd2tx.pdf |
| 71 | Appendix 3Y - Karen Penrose (ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260825/pdf/073588l8g2s087.pdf |
| 72 | Appendix 3Y - Michael Daniell | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260825/pdf/073597n2n4npk3.pdf |
| 73 | Appendix 3Y - Caroline Clarke | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260827/pdf/0739ld9jwj7ccx.pdf |
| 74 | Appendix 3Y - Michael del Prado | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 27 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260827/pdf/0739llqh2kpmdn.pdf |
| 75 | Appendix 3Y - Richard Freudenstein (sep-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 3 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260903/pdf/073nxbyl3g2w9b.pdf |
| 76 | Appendix 3Y - Diggory Howitt (nov-2025) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 13 nov 2025 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20251113/pdf/06rwc6py666wmr.pdf |
| 77 | Appendix 3Y - Christine McLoughlin (ago-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260825/pdf/07358bqygry100.pdf |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Históricos diarios de COH.AX, ^AXJO, ^AXHJ, IXJ e IHI | Yahoo Finance | Datos de mercado | 7 oct 2026 | https://finance.yahoo.com/quote/COH.AX/history |
| 79 | COH.AX: cotización de la sesión del 8-oct-2026 (chart API, regularMarketTime 16:10 AEDT) | Yahoo Finance | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/COH.AX?range=5d&interval=1d |
| 80 | Appendix 3C - Notification of buy-back (final buy-back notification) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 28 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260828/pdf/073clbrcy8rvps.pdf |
| 81 | F2 Capital Market Yields – Government Bonds (diario, publicado 02-oct-2026) | Reserve Bank of Australia | Datos de mercado | 2 oct 2026 | https://www.rba.gov.au/statistics/tables/csv/f2-data.csv |
| 82 | Cochlear Limited: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/COCHLEAR-LIMITED-6491483/finances/ |
| 83 | Cochlear Limited: Analyst Consensus | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/COCHLEAR-LIMITED-6491483/consensus/ |
| 84 | Cochlear (ASX:COH) Stock Forecast & Price Target | Stock Analysis | Datos de mercado | 5 oct 2026 | https://stockanalysis.com/quote/asx/COH/forecast/ |
| 85 | COH.AX: eventos de dividendo (chart API, events=div) | Yahoo Finance | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/COH.AX?range=2y&interval=1mo&events=div |
| 86 | Euro foreign exchange reference rates, 8 October 2026 | Banco Central Europeo | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml |
| 87 | Sonova: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/SONOVA-HOLDING-AG-70127/finances/ |
| 88 | Demant: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/DEMANT-A-S-56225597/finances/ |
| 89 | GN Store Nord: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/GN-STORE-NORD-A-S-1412917/finances/ |
| 90 | ResMed: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/RESMED-INC-14259/finances/ |
| 91 | Fisher & Paykel Healthcare: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/FISHER-PAYKEL-HEALTHCARE--6492630/finances/ |
| 92 | Straumann: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/STRAUMANN-HOLDING-AG-408695/finances/ |
| 93 | Intuitive Surgical: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/INTUITIVE-SURGICAL-INC-9740/finances/ |

| Ref. | Documento | Editor | Tipo | Fecha | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Edwards Lifesciences: Financial Data Forecasts Estimates and Expectations | MarketScreener | Datos de mercado | 8 oct 2026 | https://www.marketscreener.com/quote/stock/EDWARDS-LIFESCIENCES-CORP-12521/finances/ |
| 95 | Expanding our offering and entering new growth markets: Sonova to acquire Sennheiser Consumer Division | Sonova Holding AG | Primaria | 7 may 2021 | https://www.sonova.com/expanding-our-offering-and-entering-new-growth-markets-sonova-acquire-sennheiser/ |
| 96 | GN Store Nord to acquire SteelSeries – a global pioneer in premium software-enabled gaming gear | GN Store Nord (GlobeNewswire) | Primaria | 6 oct 2021 | https://www.globenewswire.com/news-release/2021/10/06/2309255/0/en/GN-Store-Nord-to-acquire-SteelSeries-a-global-pioneer-in-premium-software-enabled-gaming-gear.html |
| 97 | Boston Scientific Announces Agreement to Acquire Axonics, Inc. (Form 8-K, EX-99) | Boston Scientific (SEC EDGAR) | Primaria | 8 ene 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/885725/000088572524000003/pressreleasedatedjanuary82.htm |
| 98 | Globus Medical to acquire Nevro (Form 8-K, EX-99.1) | Globus Medical (SEC EDGAR) | Primaria | 6 feb 2025 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1237831/000119312525021848/d849414dex991.htm |
| 99 | Implied ERP by month (ERPbymonth.xlsx), fila de octubre de 2026 | Aswath Damodaran, NYU Stern | Datos de mercado | oct 2026 | https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xlsx |
| 100 | Cochlear to host Capital Markets Day (25-sep-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 25 sep 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260925/pdf/074hv4bxxq7wxd.pdf |
| 101 | HY26 Result - ASX & Media Release (13-feb-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 13 feb 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260213/pdf/06w84mj8zfc6np.pdf |
| 102 | Date of AGM (junta el 26-oct-2026) | Cochlear Limited (ASX) | Primaria | 17 ago 2026 | https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260817/pdf/072tdss1w0sb9z.pdf |

## Control de calidad del informe

Campos con dato: **89,1 %** · Secciones con menos del 60 % de campos cubiertos: **sentimiento** · Generado el 14 oct 2026.

Línea cotizada: la acción ordinaria de la ASX (COH); el ADR de EE. UU. no se usa. Cuentas en AUD con normas australianas (AASB, conformes con las NIIF); ejercicio a 30 de junio, nombrado por el año en que termina (FY2026 = julio de 2025 a junio de 2026). Cochlear publica semestres, no trimestres. Precio: cierre de la ASX del 8-oct-2026 (129,00 AUD); la sesión del 9-oct en Sídney aún no había abierto al cerrar el análisis [79]. La cuenta completa cubre FY2021-FY2026; de FY2016-FY2020 solo hay ventas, EBIT y beneficio del resumen plurianual [16]. El EBITDA se presenta sin el gasto en la nube (configuración de software como servicio) en todos los años: la empresa lo excluye del subyacente desde FY2026 y reexpresó FY2025; para FY2022-FY2024 se ha sacado con las cifras de cada informe anual [1, 3, 4, 5]. El consenso de EBITDA y EBIT de MarketScreener usa la misma base; su BPA de FY2027 es estatutario (con la nube) [82]. Comparables convertidos a AUD con los cambios del BCE del 8-oct-2026 [86]; GN Store Nord se deja fuera de los múltiplos por su cambio de perímetro [89].

Este documento es un análisis elaborado de forma automatizada a partir de fuentes públicas. No constituye una recomendación personalizada de inversión ni una oferta de compra o venta. Las cifras marcadas como estimación y los escenarios son hipótesis de trabajo y deben verificarse antes de tomar cualquier decisión.